

TEMA 52



LAS PERSONAS SIN HOGAR.
ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES.
ACTUACIÓN DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL.
LA TIPOLOGÍA ETHOS.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Las personas sin hogar.	
1.1.- El sinhogarismo. 1.2.- Marco legislativo. 1.3.- Los procesos de exclusión de las personas sin hogar. 1.4.- Tipología de las personas sin hogar.	
2.- Aspectos físicos, psicológicos y sociales.	
2.1.- Características sociodemográficas de las personas sin hogar. 2.2.- Contexto familiar de las personas sin hogar. 2.3.- Alojamiento de las personas sin hogar. 2.4.- Formación y situación laboral de las personas sin hogar. 2.5.- Fuentes de ingresos y gastos de las personas sin hogar. 2.6.- Salud de las personas sin hogar. 2.7.- Servicios sociales a las personas sin hogar. 2.8.- Igualdad y relación con la justicia.	
3.- Actuación del trabajador social.	
3.1.- La intervención con personas sin hogar desde el Trabajo Social. 3.2.- El modelo “Housing First”. 3.3.- El trabajo grupal en la intervención con personas sin hogar.	
4.- La tipología ETHOS.	
5.- Marco europeo y estatal para combatir el sinhogarismo.	
5.1.- Marco internacional para combatir el sinhogarismo. 5.2.- Marco europeo para combatir el sinhogarismo. 5.3.- Marco estratégico nacional de referencia.	
6.- Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España, 2.023-2.030.	
6.1.- Principios rectores. 6.2.- Visión. 6.3.- Estructura de la Estrategia Nacional.	

7.- Marco de atención a las personas sin hogar en la Comunidad de Madrid. Plan de Inclusión de Personas sin Hogar en la Comunidad de Madrid, 2.016-2.021.	
7.1.- Marco competencial. 7.2.- Objetivos. 7.3.- Enfoque. 7.4.- Ejes vertebradores.	
8.- Marco de atención a las personas sin hogar en el Ayuntamiento de Madrid.	
8.1.- Conceptualización y delimitación. 8.2.- Contexto de la Estrategia: el fenómeno del sinhogarismo en la ciudad de Madrid. 8.3.- El punto de partida. 8.4.- Contenido de la Estrategia.	

O.- INTRODUCCIÓN.

Dormir en la vía pública, mendigar, pedir dinero o comida a las puertas de una iglesia o de un supermercado, adultos acompañados por menores que ejercen la mendicidad … son escenas cotidianas para cualquier ciudadano de Madrid.

La **exclusión** constituye hoy un fenómeno social presente en nuestra sociedad, desarrollada y altamente tecnificada que muestra múltiples caras y una de ellas la encontramos en las calles de las grandes ciudades, lugar en el que observamos a personas que se encuentran en una situación clara de abandono personal y desarraigo social. Estas son las "Personas sin Hogar", grupo social muy heterogéneo y diverso, que requiere de abordajes de intervención muy especializados.

Por tanto, podemos afirmar que las Personas Sin Hogar constituyen hoy una de las formas de expresión de la exclusión de las sociedades desarrolladas. Las causas que explican su existencia son diversas y complejas. En primer lugar, cabe señalar y reconocer la existencia de **factores estructurales** presentes en nuestra sociedad, tales como: mercado laboral, política de acceso a la vivienda, rigidez e insuficiencia en la política de protección social, etc. En segundo término, y no menos importante, hay que destacar aquellas causas que se concretan en **déficit y problemáticas de carácter personal**, tales como las adicciones, trastornos mentales, soledad y aislamiento, carencia de redes de apoyo personal y familiar, etc. Todos ellos son factores de tipo personal que favorecen la instauración de los procesos de exclusión que van a dar como resultado la situación de "sinhogarismo".

Nos encontramos ante un problema de creciente magnitud, sobre todo en las grandes ciudades, que dio lugar a una **Declaración del Parlamento Europeo**, con fecha de 22 de abril de 2.008. Se estimaba que en la UE hay unos 3 millones de personas sin hogar, y otros 15 de millones que habitan en viviendas precarias. El problema de las personas sin hogar (PSH) fue planteado con carácter prioritario en las estrategias de inclusión social. Para la UE, el acceso a una vivienda digna "es un derecho humano fundamental" y el acceso a un centro de acogida es "con frecuencia, el primer paso para la resolución adecuada y sostenible del problema de vivienda de las personas sometidas a una exclusión y pobreza extremas". Dicha Declaración reconoce que todos los inviernos mueren personas congeladas en la Unión Europea, debido a la falta de alojamientos de emergencia y servicios que puedan atender sus necesidades. Se proponía que el año 2.015 se hubieran podido resolver los problemas de las necesidades de las PSH.

Entender la realidad de las personas sin hogar implica situarnos en los múltiples cambios que se han producido en el contexto social general: cambios en la estructura demográfica, altas tasas de desempleo y de precariedad laboral, encarecimiento de la vivienda y escasez de vivienda pública …Todos estos elementos han causado el debilitamiento, tanto del eje económico-laboral (trabajo precario, inestable, sueldos bajos …) como del socio-relacional (disolución de vínculos sociales, desafiliación y fragilización del entramado relacional …).

Madrid se caracteriza por un comportamiento singular en el conjunto de comunidades autónomas españolas. Lo positivo es que la región disfruta de una baja pobreza moderada en relación a los ingresos nacionales, pero se eleva a un nivel medio cuando consideramos la mediana de los propios ingresos madrileños. El rostro más negativo de la exclusión social en Madrid está formado por una alta pobreza extrema, una alta desigualdad de rentas y un alto nivel general de bienestar, pero distribuido con una alta desigualdad.

No es sencillo, ni debe hacerse un patrón que englobe a todas las personas que están en situación actual de calle, ya que el perfil es muy diverso, pero si hay datos que pueden influir en cómo estas personas, de manera general, pueden pasar el coronavirus debido a ciertas características personales, de peor manera.

1.- LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Los conceptos de "transeúnte", "sin techo", "sin hogar", "indigente" ... se utilizan generalmente de manera indistinta para enmarcar al grupo social que vive sin un hogar o un marco de inserción social definido. Hasta los años 70 se calificaba a estas personas con los términos de **vagabundos, vagos** (en plena República española, se dictó la "Ley de vagos y maleantes") e **indigentes.** En los años 70 se hizo necesario redefinir algunos términos para eliminar los componentes criminógenos y de estigma social que comportaban los utilizados y se optó por acudir al de **transeúnte.** Por "transeúnte" se entiende aquella persona que "transita", que deambula de un sitio a otro, que va de institución en institución, sin más recursos que los que lleva consigo; que busca trabajo o ayuda con una filosofía de supervivencia a corto plazo y se vincula, fundamentalmente, a la España rural de la posguerra.

Fue en el marco de la España preindustrializada de los años 40 cuando la movilidad geográfica de nuestros ciudadanos y sus implicaciones dio lugar a que la Administración tratara de dar respuesta al problema social y personal que comportaba, y para ello se crearon en el año 1.948 los primeros **albergues municipales** para hombres. Con el transcurrir del tiempo, el "transeuntismo" de la España de los 60 y 70 se asocia a las migraciones interiores.

Sin embargo, en los años 80, en el marco de una España urbana, modernizada e industrial, la crisis económica, el paro y los cambios sociales dan lugar, como un nuevo detonante, a unos fenómenos específicos que precisan una **reconceptualización** de los términos. A partir de estos momentos –y en sintonía con los enfoques desarrollados en otros países- se habla de **colectivos marginados "sin hogar" o personas "sin techo"** como característica fundamental.

En consecuencia, con el "sin techo" se engloba a todas las personas que, por carecer de vivienda, hacen de la calle o de los centros de acogida su lugar de vida, y su dimensión sedentaria los aleja conceptualmente de los "transeúntes".

Actualmente, cuando nos referimos específicamente a las personas "sin techo" o colectivos "**sin hogar**", nos referimos a un **fenómeno fundamentalmente urbano**, propio de sociedades industrializadas, aunque de hecho, en el mundo rural, se siga dando el caso del "transeúnte" de paso.

La **Fundación Rais** (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral), afirma que las personas sin hogar **no** son:

- Mendigos, solo una minoría de las PSH practica la mendicidad (14,2% según INE, 2.005).
- Vagabundos y transeúntes, las PSH son sedentarias, suelen permanecer en un lugar determinado.
- Indigentes: este término únicamente está relacionado con necesidades materiales. El término PSH pone también el acento en la falta de autoestima y de redes sociales, que permitan normalizar su situación.
- Sin techo: no es suficiente la existencia de "techo" (lo tienen las personas que habitan en recursos sociales o en pensiones). El término "hogar" hace referencia al sentimiento de pertenecer a la sociedad.

En 1.995 **Avramov** definía a las personas sin hogar como "todas aquellas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales o bien porque presentan dificultades para llevar una vida autónoma".

Fernández y Terán (1.998) afirman que las personas sin hogar "son aquellas personas que carecen de recursos económicos propios, están en paro o trabajan esporádicamente; carecen de vivienda, algunas recurren a las instituciones sociales para sobrevivir y otros rechazan su intervención, recurriendo generalmente a la limosna, no mantienen relación con su familia ni red de apoyo más extensa, sufriendo un profundo aislamiento que afecta negativamente a sus recursos y capacidades personales y que, en un último escalón del proceso de su deterioro, les lleva a la incapacidad para trabajar y mantenerse de manera autónoma".

Según el **Instituto Nacional de Estadística (INE)** una persona sin hogar "es alguien que no tiene acceso durante el período de referencia a un alojamiento que cumpla los criterios de habitabilidad humana comúnmente aceptados, tanto si el alojamiento es legalmente de su propiedad como si es alquilado, u ocupado de forma gratuita con permiso del propietario, o bajo contrato u otro acuerdo de naturaleza no temporal (incluidos los proporcionados por el sector público u organizaciones no gubernamentales y los proporcionados por empleadores).

1.1.- EL SINHOGARISMO.

El **sinhogarismo** se define como la falta de un alojamiento adecuado y permanente que proporcione un marco estable de convivencia. Es uno de los principales problemas señalados por la **Estrategia Europea de Inclusión Social**. Las nuevas políticas sociales para abordar este problema no lo consideran como una cuestión estática en cuyo origen predominan las razones personales o individuales, sino que parten de una definición situacional del mismo.

La definición de la **FEANTSA** (Federación Europea de entidades que trabajan con personas sin hogar), describe a las PSH como **"aquellas que no pueden acceder o conservar un alojamiento digno, permanente, adecuado a la situación personal y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar a cabo una vida autónoma".** Esta definición, superando visiones parciales anteriores, pone en relación elementos estructurales y biográficos.

En un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid (1.995), se señalan las funciones de una casa y las consecuencias de su carencia:

Función.	**Consecuencia de la pérdida.**
Protección de los elementos naturales.	Deshidratación, hipotermia …
Protección del delito.	Aumento del riesgo de sufrir delitos, agresiones, robos …
Lugar para descansar, recuperarse, mantener la higiene personal, lavarse …	Estrés, fatiga, irritabilidad, trastornos del sueño, desorientación, falta de higiene, enfermedades vasculares periféricas y dermatológicas …
Lugar para guardar las pertenencias.	Necesidad de llevar continuamente encima todas las pertenencias: robos, deterioro …
Lugar propio de espacio personal, estar con los amigos, refleja la personalidad, la creatividad …	Anonimato, imposibilidad de vida social, intrusión de extraños, desmoralización, mayor exposición al consumo de alcohol y otras drogas …

Una dirección, un lugar donde contactar con los amigos, los compañeros de trabajo ...	Dificultad para la búsqueda de empleo, mantener amistades, recibir correspondencia personal e institucional ...
Símbolo de pertenencia a la comunidad.	Disminución de la capacidad para participar en la vida comunitaria.
Lugar que confiere un estatus social.	Bajo estatus social, baja autoestima.
Valor económico de la casa.	Bajo estatus económico, capacidad económica disminuida para mejorar el estatus económico.

El sinhogarismo se puede describir como un **continuo de procesos y situaciones**, que deben ser diferenciados para poder darles respuestas eficaces. En estos procesos se conjugan diferentes circunstancias biográficas, momentos históricos, problemas sociales y necesidades personales.

En este enfoque situacional, las definiciones de las **personas sin hogar** oscilan entre la perspectiva más estricta que las considera sólo en referencia a la carencia de un domicilio (sinhogarismo literal o restringido) hasta aquella que no solo abarca la falta de hogar, sino todas aquellas situaciones en las que las personas afectadas viven en alojamientos que no reúnen unas condiciones mínimas para un adecuado desarrollo humano y social (sinhogarismo extenso). La opinión pública suele pensar en la exclusión como un fenómeno estrechamente vinculado a la calle, pero una mirada más profunda nos permite identificar un catálogo mucho más amplio de condiciones residenciales precarias.

Frente al perfil tradicional de PSH –varón de edad media, soltero, alcohólico, con bajo nivel formativo ...-, **Sánchez Morales** plantea que se ha producido un importante cambio en esta tipología, apareciendo en los últimos años personas con características muy diferentes:

- Varones de edad intermedia separados o divorciados.
- Varones jóvenes con problemas familiares.
- Varones jóvenes y de edad intermedia, drogodependientes o exdrogodependientes.
- Mujeres jóvenes y de mediana edad víctimas de malos tratos, separaciones o divorcios.
- Mujeres jóvenes y de mediana edad drogodependientes o exdrogodependientes.
- Personas con mayor nivel educativo y cultural.
- Enfermos mentales.
- Inmigrantes.

Las principales tendencias que se han producido son el **rejuvenecimiento del colectivo, la feminización, la presencia de grupos familiares, el mayor nivel educativo** ...

La actual situación de **crisis económica** ha provocado la aparición de nuevas realidades, entre las que podemos destacar:

- Grupos familiares viviendo en condiciones de hacinamiento o ínfima habitabilidad.
- Personas y familias desahuciadas por impago.
- Enfermos crónicos o personas mayores imposibilitadas para vivir solas.

- Personas divorciadas o separadas cuya vivienda ha pasado al cónyuge.
- Personas y familias desplazadas de su lugar habitual de residencia por múltiples razones (trabajo, temporeros, inmigrantes …).
- Personas mayores sin apoyo social.

La complejidad y magnitud de la cuestión hace que con frecuencia se asuma la definición más restrictiva, con lo que las estadísticas suelen reflejar los casos que literalmente carecen de un domicilio, viven en la calle o en centros de acogida.

1.2.- MARCO LEGISLATIVO.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1.948. "Todo el mundo tiene derecho a unas condiciones de vida adecuadas para su salud y bienestar, así como el de su familia, incluyendo alimentos, vestimentas, vivienda y asistencia social y médica" (art. 25.1.).

Unión Europea. El Consejo Europeo de Lisboa (2.000) hace de la lucha contra la exclusión social y la pobreza uno de los ejes fundamentales para la modernización del modelo social europeo. Estas medidas contra la exclusión implican acciones relacionadas con el acceso a la educación, a la vivienda, a la formación, al empleo, a los servicios sociales y a la atención médica.

La Carta Social Europea (revisada) incluye el **derecho al alojamiento** en su art. 31.

Constitución Española de 1.978.

No hay ningún artículo que se refiera de manera explícita a los derechos de las personas sin hogar, pero los podemos extraer de otros preceptos constitucionales:

- "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, renovar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social" **(art. 9.2.).**
- "No puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" **(art. 14)**.
- "Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico … realizando una política orientada al pleno empleo" **(art. 40).**
- "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" **(art. 47).**

1.3.- LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

La realidad de las personas sin hogar debemos situarlas en el contexto de los **fenómenos de fragmentación social. Robert Castel** plantea que podemos distinguir tres zonas:

- **Zona de integración**, caracterizada por el trabajo estable, la existencia de encuadre familiar, relacional y vecindad sólidos.
- **Zona de vulnerabilidad**, caracterizada por inestabilidad laboral, precariedad, intermitencia laboral y desempleo, así como una gran fragilidad en los soportes familiares y sociales.
- **Zona de exclusión y marginalidad**, ausencia de trabajo y aislamiento social.

José Félix Tezanos va a incorporar una cuarta zona al esquema de Castel, la **zona de asistencialismo**, que se sitúa entre la zona de vulnerabilidad y la zona de exclusión.

Podemos hablar, siguiendo a **Pedro José Cabrera**, de una serie de **factores desencadenantes**, entendiendo que siempre estamos hablando de procesos, no lineales, sino multicausales.

a. **Factores y conductas personales.** Problemas de personalidad, salud física y mental, adicciones …
b. **Factores o situaciones relacionales.** Separaciones, divorcios, rupturas familiares, violencia en el hogar, soledad …
c. **Condiciones estructurales o materiales.** Desempleo, escasez de la vivienda, condiciones laborales …

En una línea similar, **García Roca**, refiere que los elementos que favorecen los procesos de marginación y exclusión son:

a. **Elementos estructurales.** Constituyen la dimensión económica, caracterizada por la carencia de recursos materiales que afectan a la subsistencia. Plantea la integración por el trabajo. Supone una ruptura económica caracterizada por la escasez, la precariedad y la exclusión laboral.
b. **Elementos contextuales.** La dimensión social, caracterizada por la disolución de vínculos sociales, así como la desafiliación y fragilización del entramado relacional. Plantea la integración por la familia y la comunidad de pertenencia. Supone una ruptura social, manifestada por la vulnerabilidad vital, la transformación familiar y la movilidad social.
c. **Elementos subjetivos.** Es la dimensión personal. La integración se establece por la motivación y el sentido para vivir. Es una ruptura de la comunicación, la debilidad de los significados y la erosión de los dinamismos vitales (confianza, identidad). Supone un estado de precariedad existencial. En este contexto se desarrolla la ideología de la inevitabilidad (impotencia, victimismo, fatalismo).

Existen algunos **sucesos desencadenantes**, en el sentido que facilitan y/o provocan el inicio o repetición de ciertas situaciones relacionadas con el sinhogarismo. Según las propias personas sin hogar, estas situaciones son fracasos afectivos, acontecimientos inesperados, experiencias no asimiladas, traumas, separaciones conyugales, pérdida del puesto de trabajo, enfrentamiento con algún familiar, migración interior fracasada (años 70), inmigración, refugiados políticos …

El Indicador AROPE.

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década aprobada por el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010. En un mundo en transformación, se trata de conseguir que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades que se refuerzan mutuamente contribuirán a que la UE y sus estados miembros generen niveles más altos de empleo, productividad y cohesión social.

La Unión ha establecido para el año 2020 cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía. En cada una de estas áreas, cada estado miembro se ha fijado sus propios objetivos. La estrategia se apoya en medidas concretas tanto de la Unión como de los estados miembros.

En el apartado de integración social el objetivo nacional 2020 para España es conseguir que 1.400.000 personas menos estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

El **concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social** se amplía para considerar no solo los términos monetarios (nivel de renta), sino utilizando un **concepto multidimensional** para definir la pobreza y/o exclusión social, se incorporan los tres subindicadores siguientes:

- Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales

- Carencia material severa de bienes
- Hogares que presentan muy baja intensidad laboral

Las personas se cuentan solo una vez en el caso de estar incluidas en más de un indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social de los mencionados anteriormente. Este indicador no se aplica a las personas de 60 y más años.

Al grupo de **personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social** según la Estrategia Europa 2020 se les denomina **ERPE** (personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) o las siglas en inglés **AROPE** (At Risk of Poverty and/or Exclusión).

Las personas en riesgo de pobreza o exclusión social forman parte de los **Indicadores de Desarrollo Sostenible** dentro del Objetivo 1. Lucha contra la pobreza, difundidos por Eurostat.

Según la Estrategia Europa 2020 se consideran **personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social** a la población que se encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a continuación. **Personas que viven con bajos ingresos** (60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo en el año anterior a la entrevista), y/o **personas que sufren privación material severa** (4 de los 9 items definidos) y/o **personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja** (por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo en el año anterior a la entrevista). En caso de estar incluidas en dos o tres condiciones, las personas se contabilizan solo una vez.

Personas en riesgo de pobreza después de transferencias sociales

Personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente (después de transferencias sociales). Los ingresos corresponden al año anterior al de la entrevista.

Carencia material severa

La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos de los nueve siguientes:

1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).
5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.

6) No puede permitirse disponer de un automóvil.
7) No puede permitirse disponer de teléfono.
8) No puede permitirse disponer de un televisor.
9) No puede permitirse disponer de una lavadora.

Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo

Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos). Se calcula el número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior al 20%.

Esta variable no se aplica en el caso de personas de 60 y más años.

1.4.- TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Las tipologías son necesarias para la organización de los servicios sociales y es, precisamente, desde el marco de la asistencia social desde donde se han venido abordando los principales esfuerzos de acotación analítica. Generalmente se consideran cuatro franjas de análisis, que van desde las situaciones de riesgo o vulnerabilidad específicas, hasta situaciones leves o moderadas, afectando finalmente a las personas más desarraigadas y con mayores carencias que se integran, respectivamente, dentro de la franja avanzada y crónica.

Para la delimitación de estas franjas se utilizan cuatro variables básicas:

- Circunstancias laborales.
- Relaciones familiares.
- Estado de salud.
- Contacto con la red asistencial de los "sin hogar".

Estas variables combinadas entre sí, en función de las relaciones, contactos y cercanía de las personas en particular, pueden ubicar en uno u otro lugar de este "continuum", dando lugar a **distintos niveles de desarraigo,** así como a **respuestas asistenciales diferenciadas.**

TIPOLOGÍAS.	**Esfera laboral**	**Entorno familiar**	**Entorno relacional**	**Salud**	**Contacto con la red específica**	**Desarraigo**
Riesgo o vulnerabilidad.	+	+	+	+	-	-
Leve o inicial.	-	-	-	-	+	+
Avanzada.	--	--	--	--	++	++
Crónica.	---	---	---	---	+++ ---	+++

Entre las **personas en situación de riesgo** se encuentran aquellas que, aunque con cierto debilitamiento en las relaciones, mantienen contacto con su familia, tienen actividades laborales (en trabajos esporádicos y en precario), no padecen trastornos de índole psicológica, conservan vínculos con su entorno social y su desarraigo no es muy marcado, aun cuando, en algunos momentos, recurren a la red asistencial específica.

Las personas "sin hogar" que tienen un **grado de desarraigo inicial o leve** generalmente disponen de contactos muy frágiles con sus familias, realizan trabajos marginales y de gran inestabilidad (pueden coincidir con períodos de mendicidad), presentan síntomas de trastornos de personalidad, que pueden manifestarse en conductas adictivas (alcohol y otras drogas), establecen un distanciamiento con su entorno social y acuden ocasionalmente a la red asistencial para los "sin hogar". Dentro de esta franja, hallamos individuos que hace poco han roto los vínculos sociales o los están rompiendo, en algunos casos todavía viven en sus hogares de referencia, aunque tengan ausencias esporádicas del domicilio, conservan contactos con el entramado familiar y desarrollan algún tipo de actividad laboral (generalmente, en trabajos altamente precarios). Entre estas personas todavía no existe una dependencia muy acusada respecto de la red asistencial específica, y hábitos como el alcohol o la droga no están muy marcados. En este bloque se incluye, fundamentalmente, a jóvenes, y la organización de los servicios sociales –en su labor preventiva-, de igual forma que en la franja de riesgo o vulnerabilidad, se orienta a evitar que los vínculos sociales lleguen a quebrarse del todo.

Las personas en una **fase avanzada de desarraigo** han roto sus lazos sociales básicos, mantienen un escaso contacto familiar, se muestran ajenos al mundo laboral (los procesos de mendicidad se generalizan), sufren trastornos psicológicos y de personalidad, con pérdida de autoestima, y utilizan con frecuencia los servicios especializados de asistencia social. Son sujetos en situaciones de gran desarraigo social y sin interés por la vida, que pueden padecer problemáticas añadidas como el alcoholismo, la drogadicción e igualmente déficits muy serios de salud. Se trata de casos en los que las eventuales medidas de prevención llegan demasiado tarde y se precisan mecanismos de intervención de apoyo, de rehabilitación y de reinserción.

En el cuarto y último estadio están los **crónicos de la calle "puros y duros",** que generalmente rechazan todo tipo de atención y de ayuda institucional, bien por motivos de enfermedad mental, bien por una cierta filosofía de vida. En este mismo estadio están los **crónicos de la red**, que acuden regularmente a la red de asistencia, bien por problemas de salud mental o por características de personalidad, que viven en la calle o en los centros de acogida, que se muestran completamente desarraigados, que carecen de motivaciones y su vida se enfoca hacia la subsistencia a corto plazo. Como puede entenderse, estas personas necesitan mecanismos de intervención de acompañamiento y de programas de reducción de daños, de cara a evitar que su deterioro físico y mental se agrave y pueda poner en peligro sus vidas.

2.- ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES.

El **Instituto Nacional de Estadística** lleva varios años publicando Encuestas analizando la realidad de las personas sin hogar [1]. En el **2.012** se realizó el último de estos estudios, basándose en la población sin hogar atendida en centros asistenciales de alojamiento y de restauración en todo el territorio nacional, un total de 22.938 personas.

[1] A efectos de esta Encuesta se considera persona sin hogar aquella que tiene 18 años o más, que en la semana anterior a la de la entrevista ha sido usuaria de algún centro asistencial o de alojamiento y/o de restauración y ha dormido al menos una vez en alguno de los siguientes alojamientos ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes: albergue, residencia, centro de acogida, centros de acogida a mujeres maltratadas, centros de ayuda al refugiado, centros para demandantes de asilo, piso facilitado por una administración pública, una ONG u organismo, piso ocupado, pensión pagada por una administración pública, una ONG u organismo, espacio público (estación de ferrocarril, de autobuses, metro, aparcamiento, jardín público, descampado...), alojamientos de fortuna (hall de un inmueble, cueva, coche...)

2.1.- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Un total de 22.938 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y/o restauración en el año 2.012. La mayor parte de esta población son hombres, el 80,3%.

El 57,7% de las PSH tiene menos de 45 años, el 38,4% entre 45 y 64 años y los mayores de 64 años representan el 3,9%. La edad media de estas personas se sitúa en 42,7 años.

En cuanto a la nacionalidad, el 54,2% son españoles y el 45,8% extranjeros. El 98,0% de los españoles están empadronados en algún municipio, frente al 77% de los extranjeros.

Por lo que respecta a los extranjeros, el grupo mayoritario es el de los africanos (56,6%), seguido por los europeos (22,3%) y los americanos (15,2%). En cuanto al tiempo de residencia, los extranjeros sin hogar llevan más de cinco años en España.

	Total (valores absolutos)	**Total** (porcentajes)	**Nacional. Española** (valores absolutos)	**Nacional. Española** (porcentajes)	**Nacional. Extranjera** (valores absolutos)	**Nacional. Extranjera** (porcentajes)
TOTAL	22.938	100,0	12.425	100,0	10.513	100,0
Sexo						
Hombres	18.425	80,3	9.855	79,3	8.570	81,5
Mujeres.	4.513	19,7	2.570	20,7	1.943	18,5
Grupos de edad						
18-29	4.434	19,3	1.026	8,2	3.408	32,4
30-44	8.817	38,4	3.964	31,9	4.854	46,2
45-64	8.808	38,4	6.790	54,7	2.018	19,2
>64	879	3,9	645	5,2	233	2,2

Si se distribuye la población sin hogar por comunidades autónomas, Cataluña (21,3%), **Comunidad de Madrid (15,4%)** y Andalucía (13,1%) acumulan los mayores porcentajes. Por su parte, La Rioja (0,5%), Cantabria (1,1%) y Comunidad Foral de Navarra (1,4%) registran los más bajos.

Por cada 100.000 habitantes hay 71,3 personas sin hogar. Las mayores tasas se sitúan en las ciudades autónomas de Melilla (638,4) y Ceuta (549,9), seguidas de las comunidades de País Vasco (141,3) y Galicia (133,0). Por su parte, Castilla- La Mancha (24,4), Comunitat Valenciana (32,8), Región de Murcia (35,4) y Canarias (48,2),) registran las tasas más bajas.

Desde el punto de vista del **tiempo que llevan sin hogar**, el 31,9% de las personas llevan menos de un año sin disponer de un alojamiento, el 23,6% entre uno y tres años y el 44,5% llevan más de tres años sin alojamiento propio.

Las personas destacaron como **principales motivos por los que se quedaron sin hogar** la pérdida del trabajo (el 45,0%), no poder hacer frente al pago del alojamiento (26,0%) y la separación de su pareja (20,9%). Otros motivos fueron: cambio de localidad (13%), desahucio de la vivienda (12,1%), violencia -sufrió violencia él o sus hijos- (9,7%), estuvo privado de libertad (7,5%), hospitalización (6,8%), finalizó el contrato de alquiler (5,8%) o el edificio estaba en ruina/fue demolido/ardió (3,7%).

2.2.- CONTEXTO FAMILIAR DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Para completar las características sociales de las personas sin hogar es necesario conocer el **contexto familiar** antes y después de llegar a esta situación. El 16,2% de las personas sin hogar están casadas o tienen pareja. El 28,2% están separadas o divorciadas, el 51,7% solteras y el 3,9% viudas. Del total de personas con pareja, el 48,6% comparte su vida con ella. En cuanto a la descendencia, cinco de cada 10 personas sin hogar tienen hijos.

En relación a los antecedentes familiares, se observa que hasta cumplir los 18 años el 77,8% del total han vivido con sus padres, el 8,8% solo con su padre o su madre, el 5,8% con sus abuelos u otros familiares, el 4,2% en una institución de acogida y el 3,4% con otras personas que no eran familiares.

Las **situaciones familiares** más frecuentes vividas por las personas sin hogar hasta los 18 años han sido la falta de dinero (41,5%) y el fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar (41,6%).

Además, el 36,3% han vivido situaciones de peleas o conflictos graves entre sus padres o de violencia en la familia, y el 23,6% han sufrido la enfermedad grave de alguno de sus padres.

2.3.- ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

El 89,0% de las personas sin hogar pernocta **todas las noches en el mismo lugar**. El 43,9% ha dormido en alojamientos colectivos (el 43,2% en un albergue o residencia, el 0,5% en centros de acogida a mujeres maltratadas y el 0,2% en centros de ayuda al refugiado).

Otro 20,8% ha pernoctado en **pisos o pensiones facilitados por una ONG u organismo**S y el 35,3% restante se ha alojado al margen de la red asistencial existente, bien en espacios públicos (14,9%), alojamientos de fortuna (12,8%) o en pisos ocupados (7,6%).

Entre los que duermen en **lugares no previstos para el alojamiento** (espacios públicos y alojamientos de fortuna), el 62,7% se asea en el centro donde acuden a comer, el 61,5% en baños públicos, el 54,6% en los servicios de bares y restaurantes, el 34,7% en parques y descampados, el 29,5% en la calle y el 22,5% en la casa de un familiar y/o amigo.

2.4.- FORMACIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

En lo relativo a los **estudios terminados**, el 60,3% de la población ha alcanzado un nivel de educación secundaria, el 22,2% de estudios primarios o inferiores y el 11,8% estudios superiores. El 5,7% de las personas se declara sin estudios. La diferencia por sexo no es significativa. La edad media de abandono de los estudios fue 15,5 años.

Desde el punto de vista de la **situación laboral**, lo más destacable de la población sin hogar es su baja participación. Así, un 77,8% manifiesta no tener empleo sin estar jubilada ni incapacitada para trabajar (este porcentaje incluye tanto las personas que buscan empleo como las que no).

Por edades, el 73,7% de las personas de 18 a 29 años y el 76,6% de 45 a 64 años no tienen empleo, frente al 85,6% del grupo de edad de 30 a 34 años.

Más de la mitad de estas personas declaran estar buscando empleo (52,1%). El 38,0% lo llevan buscando entre uno y tres años, y el 17,0% desde hace más de tres.

El 3,6% del total de las personas sin hogar tienen trabajo. De ellos, el 21,0% trabajan por cuenta propia y el resto por cuenta ajena.

2.5.- FUENTES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Las principales **fuentes de ingresos** de la población sin hogar son las prestaciones públicas (Renta mínima de inserción, prestaciones por desempleo, pensiones contributivas y no contributivas y otros tipos de prestaciones públicas) que son percibidas por el 32,0% de las personas; el dinero que les da la gente de la calle (9,5%); los amigos o conocidos (8,3%) y las ONG (7,5%). Para el 8,4% la principal fuente es su trabajo.

La Renta Mínima de Inserción (RMI), prestación pública más específica para personas con problemas de integración, es percibida por el 11,4% de las personas. Otro 6,5% recibe pensiones no contributivas.

Respecto a los bienes y servicios en los que gastan mayoritariamente su dinero destacan la comida, bebida y ropa, y los servicios de transporte y alojamiento.

2.6.- LA SALUD DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

En cuanto a la **cobertura sanitaria**, el 80,2% del colectivo de personas sin hogar afirma que dispone de tarjeta sanitaria. Los extranjeros en menor medida que los españoles (el 91,1% de los españoles la tiene, frente al 67,3 de los extranjeros).

El 58,6% de las personas sin hogar declara tener **buena o muy buena salud**, mientras que el 14,2% la percibe como mala o muy mala.

La percepción del estado de salud es mejor en los hombres que en las mujeres. El 60,7% de los hombres declara tener un estado de salud bueno o muy bueno, frente al 49,7% de las mujeres.

El 30,7% de las personas manifiesta tener alguna **enfermedad crónica**. Cabe destacar la categoría de **trastornos mentales** en la que se ha clasificado el 16,6% de las personas con alguna enfermedad crónica. Estas enfermedades tienen mayor peso en las mujeres (22,3%) que en los hombres (15,0%)

También es importante destacar que el 15,2% tiene alguna **discapacidad** reconocida.

Respecto a **hábitos de vida** relacionados con la salud, el 86,4% de las personas sin hogar señala que no consume alcohol o lo hace ligeramente. Solo un 4,1% de personas manifiesta un consumo alto o excesivo de alcohol. Entre las mujeres hay más abstemias y consumidoras ligeras de alcohol que entre los hombres.

En relación con el **consumo de drogas**, el 62,7% dice que nunca ha consumido y el 37,3% que lo ha hecho alguna vez. La proporción de mujeres que consumen (24,5%) es menor que la de hombres (40,5%).

Los factores específicos de las condiciones de vida de las PSH afectan negativamente a la **calidad de vida de la salud**, resumiéndolos en tres grandes apartados:

a.- Las condiciones de vida de las PSH producen un efecto perjudicial para la **salud física**, debido a dieta deficiente, incorrecta acomodación para dormir o descansar, higiene deficiente, exposición a incidencias meteorológicas, debilitamiento general, exposición a focos de infección ...

Según algunos estudios, quienes carecen de hogar ven reducida su esperanza media de vida en 20 años.

Estos factores pueden exacerbarse por el estrés, carencia de apoyos sociales, enfermedades mentales y abuso de alcohol o drogas. En las PSH aumenta, por tanto, la exposición a factores de riesgo para contraer enfermedades.

b.- La situación de la calle obstaculiza la **administración de cuidados sanitarios adecuados**. La falta de vivienda obstaculiza el seguimiento de prescripciones o cuidados médicos, agravados por la ausencia de familiares u otros apoyos sociales.

c.- Las enfermedades físicas pueden ser la causa de la situación de las PSH, que pueden incapacitar para trabajar u obtener recursos, así como para impedir la reinserción sociolaboral.

Para analizar la situación sanitaria de este colectivo hay que hacer referencia a dos estudios, el primero lo realiza en 1.995 la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (***Informe psicosocial y epidemiológico de PSH en Madrid***), el segundo se realiza en 1.996, el estudio ***Huéspedes del aire. Sociología de las PSH en Madrid*** **(Cabrera).**

Del primer estudio podemos recoger las siguientes conclusiones:

- Identifica a las mujeres como grupo especialmente vulnerable a la enfermedad. Presentan más enfermedades de transmisión sexual, circulatorias, de huesos y músculos, de la piel …
- A mayor cronicidad, mayor aparición de trastornos y mayor comorbilidad. En el grupo de personas que lleva menos de un año en la calle, aparece una frecuencia alta de enfermedades transmisibles –VIH y trastornos hepáticos-, mientras que apenas aparecen el resto.

Los estudios realizados han confirmado que las mujeres padecen un peor estado de salud que los hombres. La tasa de prevalencia de las mujeres tiende a ser el doble que las halladas en los hombres.

Al analizar los resultados en función de la residencia habitual (calle/no calle), encontramos que en las personas con esquizofrenia las personas en instituciones presentan tasas ligeramente mayores que las que residen en la calle. La calle es un lugar que requiere ciertas habilidades mínimas de subsistencia, lo cual explica que la calle no esté poblada por personas especialmente frágiles psíquicamente.

En cuanto a los trastornos depresivos, un 12% de las personas que habitan en la calle presentan trastornos depresivos, frente a un 23% de los que habitan en instituciones. Son tasas elevadas, lo cual sugiere la existencia de serios problemas anímicos en esta población.

Podemos concluir que las PSH tienen una deficiente calidad de vida relacionada con su salud, debido a la carencia de un domicilio estable, que implica padecer las inclemencias del tiempo, malnutrición, falta de descanso adecuado … A esta situación de base se añade la gran dificultad para acceder a los recursos sanitarios. En este sentido, podemos señalar que:

- El alojamiento en centros y albergues se demuestra fundamental para la detección, seguimiento y prevención secundaria de enfermedades, constituyéndose en una herramienta de primer orden para evitar el contagio a la población en general.
- El hecho de que la prevalencia de enfermedades sea superior en los albergues y centros de acogida que en la calle, significa que son un dispositivo eficaz para el diagnóstico y tratamiento. A las personas que están en la calle les resulta poco menos que imposible obtener el diagnóstico de su enfermedad, si no es puntualmente en los servicios de urgencia. Mucho más difícil es mantener un tratamiento adecuado.
- Las intervenciones de los profesionales son fundamentales en la gestión para el acceso al recurso, movilizando los medios de las instituciones como los acompañamientos y los traslados, facilitando información a los profesionales sanitarios, procurando la medicación …
- Igualmente son fundamentales para el apoyo cotidiano al tratamiento, para la comprensión del diagnóstico y tratamiento, y, en general, para la educación y el cuidado de la salud.

- El establecimiento de programas específicos para determinadas patologías en los centros de acogida y albergues, adaptados a las necesidades de las PSH, son herramientas imprescindibles, siempre que contemplen el principio de normalización, es decir, posibiliten el acceso a los recursos de igual manera que accede el resto de la población.

2.7.- SERVICIOS SOCIALES A LAS PERSONAS SIN HOGAR.

Los servicios sociales dirigidos a personas sin hogar, especialmente vulnerables y excluidas o en riesgo de exclusión social, tienen como finalidad cubrir sus necesidades básicas.

Las personas sin hogar solicitan principalmente, además de los servicios de alojamiento (60,2% de las personas) y comedor (67,3%), incluidos en la definición de persona sin hogar a efectos de esta encuesta, otros servicios sociales como los de información, orientación y acogida (56,7%) y los servicios de higiene (53,6%).

Los servicios más concedidos a las personas sin hogar son los de comedor (64,2%), el de orientación, información y acogida (55,2%) y el alojamiento (49,5%).

En cuanto a la opinión que tienen las personas sin hogar sobre las ayudas que han recibido, el 55,6% opina que le ayudaron bastante o mucho, mientras que el 44,4% opina que le ayudaron poco o nada.

2.8.- IGUALDAD Y RELACIÓN CON LA JUSTICIA.

Un factor importante asociado a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social de las personas sin hogar es su exposición a las agresiones o delitos.

El 51% de las personas sin hogar han sido víctima de algún delito o agresión. Los delitos y agresiones más frecuentes han sido los insultos y amenazas, robos y agresiones.

Por otra parte, el 76,1% de las personas sin hogar se sienten poco o nada discriminadas. El 9,8% manifiesta sentirse muy discriminada.

Por nacionalidad, el 71,3% de los españoles se sienten nada o poco discriminados, frente al 81,9% de los extranjeros.

Por último, y respecto a su relación con la justicia, cabe destacar que el 44,7% de las personas sin hogar han sido detenidas o denunciadas alguna vez. De ellos, casi la mitad ha sido condenada por los tribunales.

Por nacionalidad, los españoles superan a los extranjeros (el 55,2% de los españoles ha sido condenado alguna vez, frente al 32,3% de los extranjeros).

3.- ACTUACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL.

La intervención con PSH se ha caracterizado tradicionalmente por la escasez de criterios de intervención, prestaciones limitadas al alojamiento y a la comida, carencia de equipamientos adecuados y de profesionales cualificados, atendidos por voluntarios sin formación técnica … Este modelo respondía a un **modelo expulsivo** y mantenedor de las situaciones de exclusión.

Hace ya algunas décadas que se ha consolidado un **cambio progresivo en los modelos de atención**, caracterizado por:

- Incorporación de técnicos y personal especializado.
- Mejoras en las condiciones de acogida y alojamiento.
- Diversificación de programas enfocados a la inserción social y laboral.
- Nuevas fórmulas de financiación.
- Desarrollo de estructuras de coordinación.

Por lo tanto, junto a los dispositivos más clásicos –albergues, comedores, roperos …-, encontramos los Centros de Día, los Centros nocturnos de baja exigencia, los equipos de calle, los talleres ocupacionales y prelaborales, las empresas de inserción …

3.1.- LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR DESDE EL TRABAJO SOCIAL.

3.1.1.- LA PREVENCIÓN DEL SINHOGARISMO.

La prevención de estas situaciones ha de entenderse desde una doble dimensión:

- **Detección precoz** en personas que se encuentran en las primeras fases de desarraigo y marginación, es decir, prevención desde las causas sociales que originan el proceso.
- Prevención desde la **dinámica y organización de los servicios específicos** para los "sin hogar".

Las primeras medidas preventivas se relacionan con la **política de vivienda**. Desde la perspectiva de la prevención precoz la vivienda es un **factor de integración social** de primer orden, de forma que, si hubiese una política social que permitiese considerar la vivienda no como un elemento de capital y de propiedad, sino como un bien social, las personas muy desfavorecidas económicamente, las que se encuentran en procesos de desarraigo, tendrían un elemento de protección más adecuado.

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de la población media española, al que se dedica una parte muy significativa de los ingresos familiares, mientras que el parque de alquileres sigue siendo muy limitado.

Los más afectados por la política de viviendas son los jóvenes que desean independizarse, las personas que residen en infraviviendas, los sectores sociales que padecen procesos de crisis social y, lógicamente, los "sin hogar".

Medidas para la población general.	**Medidas específicas para el colectivo de los "sin hogar".**
. Política de promoción de vivienda pública. . Fomento del mercado del alquiler con la posibilidad de garantías institucionales del pago. . Creación de un fondo de garantía para impedir los desahucios. . Políticas de incentivación del uso de viviendas vacías en las grandes ciudades.	. Facilitar el empadronamiento de las personas indomiciliadas. . Eliminar o flexibilizar el requisito del empadronamiento para acceder a determinados derechos sociales. . Desarrollo de apoyos y ayudas para el alojamiento de las personas dependientes de las rentas mínimas de inserción.

. Diversificación de los tipos de viviendas. . Formalización de políticas de vivienda social en el mundo rural.	. Cesión de viviendas públicas para colectivos con especiales dificultades. . Formalización de fórmulas alternativas de alojamiento. . Regulación jurídica de los albergues y de los derechos de los usuarios. . Necesidad de un acompañamiento social en procesos de reinserción. . Adecuada coordinación entre las diferentes administraciones y las iniciativas públicas y privadas.

En el caso concreto de los "sin hogar" se priorizan como alternativas más eficaces a los centros de acogida y a la vida en la calle –y como paso previo a la autonomía personal- las **semiresidencias, pisos compartidos, pisos tutelados ...,** tanto para las personas situadas en las primeras fases de desarraigo como para los más avanzados.

La mayor parte de las Comunidades Autónomas españolas cuentan con proyectos de apoyo, a través de pisos compartidos, para esta población. En cualquier caso, las medidas que se adopten en el ámbito de la vivienda deben situarse dentro del contexto general de las políticas sociales, en las cuales los programas de formación y los programas laborales son básicos.

Por tanto, una segunda medida preventiva, sería la **promoción de una política adecuada de empleo** que garantice la estabilidad y los entornos económicos normalizados para toda la población. En este sentido hay que plantear **alternativas de empleo específicas y fórmulas de reinserción laboral para los "sin hogar",** por ejemplo, a través de las empresas sociales.

Una tercera medida de prevención debe consistir en la **formulación de programas contra el alcoholismo**, al igual que ya existen los programas de lucha contra las drogas.

Una cuarta medida preventiva requiere una **coordinación fluida entre las distintas administraciones y una cercanía real de las instituciones generales de asistencia** a los ciudadanos con mayores dificultades, de manera que puedan recibir un apoyo integral en fases de procesos de desarraigo. Estos procesos exigen una buena acogida para los individuos que acuden por primera vez a la red asistencial específica, facilitándoles el acceso a las estructuras sociales normalizadas –Servicio Público de Empleo, recursos de formación, recursos de empleo ...-.

Finalmente, la prevención desde esta perspectiva integral plantea la necesidad de un debate profundo sobre la operatividad y eficacia de los modelos asistenciales al uso, buscando, en último término, **generar alternativas a la asistencia tradicional.**

En último lugar, hay que promover **políticas que favorezcan las redes de solidaridad ciudadanas y familiares,** que contrarresten la tendencia hacia procesos de individualización, marcados por un modelo social que prima la competencia y la desigualdad por encima de otro tipo de valores.

3.1.2.- LA INTERVENCIÓN Y REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR.

La rehabilitación y posterior reinserción de los "sin hogar" pasa por una **intervención individualizada** conforme a la trayectoria de estas personas, sus deseos, los medios disponibles, ... Se trata de propiciar una dinámica en la que se van compartiendo con ellos la consecución de metas y se va recorriendo –lentamente- el camino que antes han andado en sentido contrario.

En este tipo de intervenciones la **motivación del sujeto** es fundamental, y para ello se han creado **mecanismos de acercamiento** a los individuos más aislados, por ejemplo, mediante **centros de baja exigencia** en los que se ofrecen una serie de servicios, pero sin plantear obligaciones o normativas demasiado estrictas.

Además, se está realizando un **trabajo de acercamiento a los crónicos de la calle** a través de procesos de contacto para ganar su confianza y, a partir de esa relación, tratar de mejorar su calidad de vida.

En resumen, cuando se habla de rehabilitación, nos referimos a la posibilidad de recorrer un **itinerario hacia la integración social.** Hay que ser conscientes, sin embargo, que esta trayectoria es más complicada a medida que el aislamiento y el deterioro personal ha sido más acusado; y más sencilla cuando se ha logrado mantener algunos vínculos relacionales y cuando se cuenta con una relativa autonomía personal y autoestima.

En principio la reinserción es siempre posible, aunque con frecuencia parece imposible ya que los elementos estructurales siguen inalterables. Este recorrido hacia la integración no debemos entenderlo desde los parámetros de las personas que están (y lo han estado normalmente) en una situación de integración social –es decir, desde modelos de trabajo y de familia normalizados-, ya que es muy difícil alcanzar esos objetivos. Hay que tender hacia una **integración social personalizada**, según las posibilidades y limitaciones de cada individuo. La **autonomía** se entiende como la posibilidad de alcanzar un cierto "pulso vital" para mantenerse de forma autónoma, con una serie de recursos que –a ser posible- provengan de fuentes normalizadas.

Podemos apreciar tres componentes que apuntan a la factibilidad de la reinserción:

- Cuando la persona tiene acceso a una **vivienda digna.**
- A un **empleo** que le permite la cobertura de sus necesidades fundamentales.
- A un estado razonable de **salud** (o las posibilidades de sanarse si ésta falla).

Al tratarse de un grupo social con particularidades asociadas a desarraigos personales y sociales, la rehabilitación nos sitúa en el plano de la recuperación personal, y para eso es necesario devolverles su autoestima, la confianza en ellos mismos, en el futuro y en la sociedad. A partir de los talleres de autoestima se puede comenzar a trabajar el desarrollo de habilidades sociales, de elementos de alfabetización, de formación laboral ...

Si nos referimos a la rehabilitación de personas con problemáticas añadidas –consumo de alcohol, drogodependencias, ludopatías ...-, este proceso pasa necesariamente por etapas de deshabituación.

Posteriormente la reinserción social exige **cursos formativos para el empleo** y una recuperación, readecuación o reaprendizaje de las habilidades y hábitos laborales y profesionales.

En paralelo a este aprendizaje social, laboral-formativo y personal, hay que trabajar también en el ámbito de la **recuperación de las redes sociales.**

3.2.- EL MODELO "HOUSING FIRST".

Housing First es seguramente la innovación más importante de los últimos 30 años en el diseño de servicios para personas sin hogar. Desarrollado por **Sam Tsemberis** en Nueva York, el modelo Housing First ha demostrado tener éxito en erradicar el sinhogarismo de las personas con grandes necesidades de apoyo en EE.UU. y Canadá y en varios países europeos. Housing First está diseñado para personas que necesitan niveles significativos de ayuda para poder salir del sinhogarismo. Entre los grupos a los que los servicios Housing First pueden ayudar se encuentran **personas sin hogar con enfermedad mental severa o problemas de salud mental, con consumos problemáticos de drogas y alcohol, y/o con salud física delicada, enfermedades limitantes y discapacidades**.

Los servicios Housing First también han demostrado ser efectivos en **personas con trayectorias de situación de calle largas o recurrentes** que, además de otras necesidades de apoyo, a menudo carecen de apoyos sociales, por ejemplo, de amistades o familiares y que no forman parte de una comunidad. En Estados Unidos y Canadá, los programas Housing First también se utilizan con familias sin hogar y con personas jóvenes.

Housing First **utiliza la vivienda como punto de partida más que como objetivo final**. En un servicio Housing First lo primero que se proporciona antes que cualquier otro tipo de apoyo o intervención es el alojamiento, y por eso se denomina Housing First ("Vivienda Primero"). Un servicio Housing First es capaz de focalizarse de manera inmediata en que una persona se mantenga alojada satisfactoriamente en su propio hogar formando parte de una comunidad. Pero Housing First también busca mejoras en la salud, el bienestar y las redes de apoyo social de las personas sin hogar con las que se trabaja. Este enfoque es muy diferente al de los servicios que intentan conseguir que las personas sin hogar con grandes necesidades de apoyo estén "preparadas" para acceder a una vivienda antes de ofrecérsela.

Algunos modelos existentes de servicios para personas sin hogar exigen a las personas usuarias que mantengan la sobriedad y respeten la adherencia a los tratamientos, y las forma para que puedan vivir de manera independiente antes de ofrecerles alojamiento. En este tipo de servicios para personas sin hogar el alojamiento llega lo "último". Housing First está diseñado para garantizar que las personas sin hogar tengan un alto grado de elección y control. Los servicios Housing First fomentan activamente la reducción del daño en consumos de drogas y alcohol y la participación en tratamiento de las personas usuarias; pero no están obligadas a ello.

Otros servicios para personas sin hogar, como los del "**sistema en escalera**" ("**continuum of care**"), a menudo obligan a las personas sin hogar a participar en un tratamiento y a mantener la abstinencia de drogas y alcohol antes de que se les permita el acceso a una vivienda. Además, pueden expulsar también a una persona de su alojamiento si no sigue el tratamiento o no mantiene la abstinencia de drogas y alcohol.

Diferentes estudios en EE.UU., Canadá y Europa muestran que Housing First saca generalmente del sinhogarismo a al menos ocho de cada diez personas. También se ha observado un éxito similar con diferentes grupos de personas sin hogar. Housing First ha funcionado muy bien con personas que no están bien integradas en la sociedad después de una situación de sinhogarismo de larga duración o que han estado en esa situación de manera recurrente, con personas sin hogar con enfermedad mental severa y/o con uso problemático de drogas y alcohol y con personas sin hogar con salud física débil.

Antes de Housing First, sólo se ofrecía alojamiento permanente con apoyo a personas sin hogar después de que hubiesen pasado por una serie de etapas que empezaban por el tratamiento y la abstinencia. Cada etapa de esta "escalera" estaba diseñada para preparar a las personas a vivir de manera independiente en su propio hogar. Cuando se habían completado todas las etapas, quien previamente había sido una persona sin hogar con problemas de salud mental debía estar "preparada para el alojamiento", ya que se le había "formado" para vivir de manera independiente. A este tipo de servicios se les denomina habitualmente "de escalera", "tratamiento lineal residencial" o "enfoque basado en el tratamiento".

Inicialmente, estos **servicios "de escalera"** y la **cultura de "aptitud para el alojamiento"** habían surgido de la práctica de los hospitales psiquiátricos norteamericanos, donde las personas con diagnosis de enfermedad mental severa eran consideradas como incapaces funcionales en todas las áreas de su vida y necesitaban de atención y supervisión las 24 horas del día. Alrededor de los años 80, algunos/as profesionales de salud mental comenzaron a plantear serias dudas sobre la efectividad de los servicios basados en estas asunciones sobre la enfermedad mental severa. Aun así, el enfoque de escalera se estableció firmemente en Norteamérica como el modelo para ayudar a las personas sin hogar con grandes necesidades.

El hecho de dar a las personas usuarias **mucha más capacidad de elección sobre cómo vivían sus vidas**, a la vez que se fomentaban cambios positivos y se les proporcionaba ayuda cuando la solicitaban, demostró ser más efectivo que el enfoque de escalera. Este modelo de alojamiento con apoyo fue la base de Housing First6. La mayor parte de los servicios para personas sin hogar por tanto siguieron el modelo de escalera.

En Europa los servicios para el sinhogarismo también habían sido diseñados de acuerdo con un enfoque de escalera, que entendían la vivienda como el fin último más que como el primer paso para acabar con el sinhogarismo. Las investigaciones que se hicieron sobre los servicios de escalera para personas sin hogar mostraron la existencia de problemas similares a los identificados en los servicios de escalera para personas con problemas de salud mental.

En concreto:

- Las personas sin hogar se quedaban "atascadas", ya que no conseguían completar las etapas que se esperaba que cumpliesen antes de ser alojadas.
- Las personas sin hogar que no podían avanzar en las etapas o a las que no les gustaban las estrictas reglas de los servicios de escalera dejaban de acudir a estos servicios.
- Se planteaban dudas sobre la ética de algunos de los servicios de escalera, en especial sobre la tendencia a ver el sinhogarismo como resultado de los defectos de las propias personas, que acababa culpando a las personas sin hogar de causar su propia situación de sinhogarismo.
- Los servicios de escalera podían ser entornos duros para las personas sin hogar.
- Los costes de los servicios de escalera eran altos, mientras que su eficiencia a menudo era limitada.

Los **principios fundamentales** en los que se sustenta este modelo son:

La vivienda es un derecho humano.	El **Comité de la ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales** estableció un derecho a la vivienda según el cual cualquier persona debería poder vivir en seguridad, paz y dignidad.
Elección y control para las personas usuarias.	**Un principio clave de Housing First es que se debe escuchar a las personas que utilizan el servicio y respetar sus opiniones.** Una persona usuaria de Housing First tiene la capacidad de tomar decisiones reales sobre cómo quiere vivir su vida y sobre el tipo de apoyos que va a recibir.
Separación de vivienda y tratamiento.	**Housing First garantiza que el derecho humano a la vivienda no está comprometido por la obligación de las personas usuarias de seguir un tratamiento ya sea para acceder a la vivienda o para permanecer en ella.** La vivienda, por tanto, está separada del tratamiento.
Orientación a la recuperación.	**Un servicio que tiene un enfoque de recuperación se centra en el bienestar general de la persona. El bienestar incluye su salud física y mental, su grado de apoyo social (de su pareja, familia o amistades) y su grado de integración social, por ejemplo, el hecho de formar parte de una comunidad y de participar activamente en la sociedad.** Favorecer el acceso a la educación o ayudar a encontrar una actividad de ocio reconfortante puede ser una de las maneras de promover la recuperación. Un enfoque de recuperación es mucho más amplio y más ambicioso que trabajar con la persona su consumo de drogas y alcohol o fomentar su participación en un tratamiento. Se trata de conseguir una vida segura y reconfortante para la persona, y generar un contexto que consiga, en un sentido amplio, su integración en la comunidad, en la vivienda y en una vida social y económica positivas.

Reducción del daño.	**El enfoque de reducción del daño se basa en la idea de que acabar con el uso problemático de drogas y alcohol puede ser un proceso complejo y que los servicios que exigen abstinencia o desintoxicación no funcionan bien para muchas personas sin hogar.** La reducción del daño es una práctica normalizada en algunos países del norte de Europa, como Finlandia o Reino Unido y se utiliza desde hace años en Francia, pero no es una práctica universal en toda Europa. **Hay evidencia más que suficiente para demostrar que la reducción del daño es más efectiva para ayudar a personas sin hogar con necesidades grandes o complejas que los servicios basados en la abstinencia o la desintoxicación.** En la reducción del daño, se entiende que los problemas derivados del uso de drogas o alcohol son resultado de otros factores que necesitan atención y se ven también como un factor que puede complicar o aumentar otras necesidades de apoyo. Es decir, se entiende que el consumo de drogas no puede tratarse o abordarse de manera independiente, sino que debe ser contextualizado en relación a otras necesidades, características o comportamientos de la persona.
Compromiso activo sin coerción.	El compromiso activo sin coerción, tal y como se entiende en Estados Unidos, se puede describir como un modo de trabajo con las personas usuarias de Housing First asertivo y sobre todo no agresivo. Este enfoque trata de crear un vínculo positivo con las personas usuarias que les haga sentir que la recuperación es posible. Es la misma técnica que usa Housing First en el enfoque de recuperación. **En los enfoques de reducción del daño y orientación a la recuperación en Housing First, se pone énfasis en tratar de que las personas usuarias se comprometan positivamente con la ayuda que necesitan.** También se les pide que tengan una mirada constructiva sobre aquellos aspectos de su comportamiento que podrían suponer un riesgo para su salida del sinhogarismo o para su salud, bienestar y calidad de vida.
Planificación centrada en la persona.	Los servicios Housing First utilizan una planificación centrada en la persona, que esencialmente consiste en organizar el apoyo y el tratamiento en torno al individuo y a sus necesidades. Este enfoque insiste en la capacidad de elección de la persona usuaria y su control sobre el servicio. Podría resumirse diciendo que Housing First se adapta y organiza alrededor de las personas usuarias del servicio, en vez de pretender que sean las propias personas las que se adapten al servicio Housing First. Un servicio Housing First alienta y ayuda a las personas usuarias a decidir el tipo de vida que quieren vivir. La elección y el control desempeñan un papel importante para ello, de modo que, en los servicios Housing First, las personas usuarias toman decisiones reales sobre los tipos de apoyo y de tratamiento**.**
Apoyo flexible y disponible durante el tiempo necesario.	Si alguien pierde su casa, el servicio Housing First no le abandona a su suerte, sino que sigue comprometido e intenta asegurar el derecho de la persona a la vivienda. Housing First ofrece un apoyo diseñado para dar respuesta a las necesidades de la persona. Esta característica fundamental de los servicios Housing First se ve reforzada por el énfasis en la elección y el control, la planificación centrada en la persona, la orientación a la recuperación y la reducción del daño.

	El apoyo es adaptable, flexible y puede ser imaginativo, respondiendo a cada conjunto de necesidades individuales según lo requieran, al menos dentro de los recursos (económicos) del servicio Housing First. **La intensidad del apoyo puede aumentar o disminuir según las necesidades del individuo, así que Housing First debe responder positivamente cuando la persona necesite más o menos ayuda.**

3.3.- EL TRABAJO SOCIAL GRUPAL EN LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR.

En el trabajo grupal existen objetivos y nexos comunes que tienen que ver con la mejora de relaciones, con la ruptura del aislamiento y con la creación o recuperación de la confianza para crear vínculos.

La Asociación Realidades desarrolla en Madrid, desde el año 1.992, un proyecto de atención psicosocial para PSH, ofreciendo actuaciones de acompañamiento individual y diferentes actividades de grupo.

El **marco teórico de referencia** de esta propuesta descansa en el **enfoque sistémico** –como marco general de comprensión de las situaciones y relaciones humanas-, el **enfoque rogeliano**, la **Gestalt** y teorías de **dinámica de grupos.**

- El enfoque sistémico indica que el grupo es un todo interrelacionado, diferente a la suma de sus individuos. Dentro del grupo es muy importante tener en cuenta la complejidad de las situaciones y de las relaciones personales.
- El enfoque centrado en la personalidad (Rogers) es muy útil para comprender las vivencias y poder desarrollar unas actitudes que faciliten una comunicación clara. Rogers parte de la base de la importancia del marco de referencia interno de la persona, su mundo de significaciones. La empatía, la congruencia, la aceptación … son fundamentales para crear un clima libre de amenazas.
- La Gestalt pone el acento en la integración de todas las facetas del individuo, trata de ampliar la capacidad de darse cuenta del mundo interno y del mundo exterior.

El hecho de que percibamos la posibilidad de pertenecer a un grupo hace surgir en las personas sentimientos, temores, necesidades … la necesidad de ser aceptado, de pertenencia, de afecto, de comunicación …

La **metodología** implica centrarse en el trabajo con las personas, no solo en sus problemas. Es fundamental trabajar desde lo positivo, las ilusiones y las capacidades de las personas que forman el grupo. El grupo trata de recuperar y revitalizar estas capacidades. La actitud del trabajador social debe ser la de facilitar la comunicación, la escucha, la confianza, el darse cuenta. También tendrá un papel mediador en los diferentes conflictos que se puedan producir en el seno del grupo.

4.- LA TIPOLOGÍA ETHOS.

La vivienda constituye un espacio básico de estructuración de la vida personal, familiar y social. Quizá, por ello, las personas sin hogar suelen ser la imagen más representativa de la gravedad en la que pueden derivar los procesos de exclusión social.

Esta es la preocupación que subyace en el **Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El problema de las personas sin hogar**», aprobado en octubre de 2011 (documento en español 2012/C 24/07). En dicho informe se recomienda el uso de la **tipología ETHOS**, propuesta por la **Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin hogar (FEANTSA),** para promover la elaboración de estadísticas homogéneas a nivel europeo y el uso de definiciones e indicadores comunes en el análisis de la exclusión residencial.

La **tipología ETHOS** (**European Typology on Homelessness and Housing Exclusion**) fue formulada en 2005 por FEANTSA y tras ser revisada, en los dos años siguientes, se ha constituido en la principal referencia para el estudio de las personas sin hogar.

Según ETHOS, tener una vivienda supone disponer de ella en **tres ámbitos o dominios básicos: legal, social y físico.**

Desde el **punto de vista jurídico**, disponer de una vivienda significa tener un título legal (en propiedad o en alquiler) sobre la misma, lo que confiere seguridad en la ocupación y tenencia en exclusiva. El **ámbito social** de uso hace referencia a que tener una vivienda permite mantener privacidad y disfrutar de relaciones sociales. Por último, disponer de un alojamiento decente y adecuado a las necesidades de la persona y su familia constituye el **dominio físico** de la vivienda; definido, por tanto, en cuanto a sus condiciones de habitabilidad.

La existencia de carencias en alguno, o varios, de los ámbitos de uso (legal, social y físico) se traduce en cuatro categorías principales en las que se puede clasificar a las personas sin hogar, según su situación en relación con la vivienda (FEANTSA, 2007):

- **Sin techo** (sin alojamiento de ningún tipo, es decir, viviendo en un espacio público).
- **Sin vivienda** (viviendo en un alojamiento temporal, en instituciones o albergues).
- **Vivienda insegura** (viviendo bajo amenaza de desahucio, arrendamiento precario o violencia doméstica).
- **Vivienda inadecuada** (viviendo en chabolas de asentamientos ilegales, en alojamientos que incumplen la normativa sobre habitabilidad o en situación de hacinamiento).

Si bien, la clasificación ETHOS va referida al sinhogarismo y la exclusión en vivienda, su uso se ha orientado mayoritariamente al estudio de las personas sin hogar; dado que todas sus categorías contemplan situaciones de cierta gravedad, que hacen posible hablar de sinhogarismo en sentido estricto (sin techo o sin vivienda) o en términos más amplios (vivienda insegura o inadecuada).

Sin duda, la categoría **Sin Techo** no sólo es la situación más grave de exclusión residencial, sino también de exclusión social, al añadirse a la ausencia de alojamiento diversas desventajas en múltiples dimensiones sociales. Y es que el hecho de vivir en la calle no puede sino agravar más cualquier situación previa. En palabras de Pedro Cabrera, "muchas de las conductas especiales o extrañas de quienes se encuentran sin techo, no son sino una respuesta adaptativa a las condiciones extremas en que viven" (Cabrera, 2008: 188).

Categoría conceptual	Categoría operativa	Situación residencial	Definición
SIN TECHO	**1.- Vivienda en un espacio público (viven a la intemperie).**	1.1.- Espacio público y exterior.	Durmiendo en la calle o espacios públicos, sin un albergue.
	2.- Duermen en un refugio nocturno y/o se ven obligados a pasar varias horas al día en un espacio público.	2.1.- Albergue o refugio nocturno.	Personas sin un lugar habitual donde residir, que hacen uso de albergues o centros de alojamiento de muy baja exigencia.
SIN VIVIENDA	**3.- Personas que viven en albergues y centros para gente sin hogar / alojamiento temporal.**	3.1.- Albergues y centros de alojamiento. 3.2.- Alojamiento temporal y de tránsito. 3.3.- Alojamiento con apoyo.	Cuando la estancia es entendida a corto o medio plazo y de forma temporal, no como lugar de residencia definitiva.
	4.- Personas en albergues para mujeres.	4.1.- Albergues para mujeres (solas o con hijos).	Mujeres alojadas debido a que han sufrido violencia de género, siempre y cuando se entienda como residencia temporal.
	5.- Personas en centros de alojamiento para solicitantes de asilo e inmigrantes.	5.1.- Alojamiento temporal / centros de recepción. 5.2.- Alojamientos para trabajadores temporeros.	Inmigrantes en centros de recepción o de alojamiento temporal debido a su condición de inmigrantes / Centros de repatriación (internamiento para extranjeros).
	6.- Personas que en un plazo definido van a ser despedidas de instituciones residenciales o de internamiento.	6.1.- Instituciones penales (cárceles). 6.2.- Instituciones sanitarias (hospitales). 6.3.- Centros de menores.	Sin vivienda disponible en la excarcelación. Estancia mayor de la estrictamente necesaria por la falta de vivienda. Sin vivienda a la que dirigirse al cumplir la mayoría de edad.
	7.- Personas que reciben alojamiento con apoyo sostenido, debido a su condición de personas sin hogar.	7.1.- Residencia para personas sin hogar mayores. 7.2.- Vivienda tutelada y con apoyo a largo plazo para personas anteriormente sin hogar.	Alojamiento con apoyo de larga estancia para personas que han vivido sin hogar.

VIVIENDA INSEGURA	**8.- Personas viviendo en un régimen de tenencia inseguro / sin pagar el alquiler.**	8.1.- Viviendo acogidos por familiares. 8.2.- Sin tenencia legal (ej. Subalquilados). 8.3.- Ocupación ilegal.	Residiendo en un alojamiento convencional pero que no es el habitual, debido a la pérdida de su vivienda. Ocupación ilegal o sin ningún tipo de garantía jurídica para residir en ese alojamiento.
	9.- Personas viviendo bajo amenaza de desahucio.	9.1.- En régimen de alquiler. 9.2.- Con la vivienda en propiedad.	Con orden de desahucio, por impago de alquiler. A punto de verse expropiados, por impago de la hipoteca.
	10.- Personas que viven bajo amenazas de violencia por parte de la pareja o de la familia.	10.1.- Con denuncias presentadas ante la policía.	Cuando ha actuado la policía y/o los centros de intervención rápida para tratar de encontrar un alojamiento seguro y a salvo.
VIVIENDA INADECUADA	**11.- Personas viviendo en estructuras temporales y no convencionales.**	11.1.- Caravanas y similares. 11.2.- Edificaciones no convencionales ni pensadas para que residan personas. 11.3.- Estructuras temporales.	No pretenden que sea la vivienda habitual. Edificios autoconstruidos como chabolas o chozas. Estructuras semipermanentes como chabolas.
	12.- Alojamiento impropio.	12.1.- Edificio ocupado que no es apropiado para vivir en él.	Edificios definidos como no habitables por la ley.
	13.- Hacinamiento extremo.	Muy por encima de los estándares habituales que marca el hacinamiento.	Por encima de las normas nacionales de hacinamiento.

Estas cuatro categorías conceptuales se subdividen en **trece categorías operativas** para el análisis de los problemas derivados de la carencia de vivienda y para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas (Comité Económico y Social Europeo, 2011).

- En la **categoría Sin techo** todos los ámbitos de uso de la vivienda (legal, social y físico) están en exclusión. Además, en cada uno de estos ámbitos se podría decir que concurren todos los tipos de limitaciones que venimos considerando (accesibilidad, estabilidad, adecuación y habitabilidad).
- Las personas incluidas en la **categoría Sin vivienda** tienen cubierta su necesidad de alojamiento, en condiciones de habitabilidad y adecuación desde el punto de vista físico, y con cierto horizonte temporal, medio-largo plazo. Sin embargo, en los ámbitos de uso legal y social, estas personas no tienen acceso a una vivienda propia, ni sus condiciones de alojamiento son estables y tampoco pueden ser adecuadas a sus necesidades particulares, al tratarse en su mayoría de hogares colectivos.

- En todas las situaciones residenciales correspondientes a la **categoría Vivienda insegura** no hay certeza en la tenencia de la vivienda (ámbito legal), lo que se traduce en limitaciones en el acceso al bien vivienda y en las posibilidades de un uso estable del mismo.
- La última de las categorías que establece la tipología ETHOS para abordar la exclusión residencial se refiere a la **categoría Vivienda inadecuada**. Aquí los dominios de uso afectados por limitaciones en la adecuación y habitabilidad son el físico y el social. Dado un escaso nivel de ingresos, se trata de alojamientos accesibles y estables para el hogar, pero que no son adecuados ni reúnen las condiciones de habitabilidad.

5.- MARCO EUROPEO Y ESTATAL PARA COMBATIR EL SINHOGARISMO.

5.1.- MARCO INTERNACIONAL PARA COMBATIR EL SINHOGARISMO.

El **derecho a una vivienda adecuada** está consagrado en el **artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1.948** y en el **artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1.966,** así como en otros tratados internacionales de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas fue el primer mecanismo internacional de Derechos Humanos que concretó detalladamente el contenido del derecho a una vivienda adecuada en su **Observación general N.º 4**, relativa al derecho a una vivienda adecuada (1991), y en su **Observación general N.º 7,** relativa a los desalojos forzosos (1997). Posteriormente, el 17 de abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos adoptó la Resolución 2000/9 en la que se decidió nombrar, un **Relator Especial,** inicialmente por un período de tres años, cuyo mandato se centrara en la vivienda adecuada como elemento integrador del derecho a un nivel de vida adecuado. El Relator Especial ha elaborado varias directrices para los Estados, los Gobiernos locales y otros agentes, basadas en las normas de Derechos Humanos vigentes.

Por su parte, la **Agenda 2.030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** son un marco integral centrado en los Derechos Humanos, las personas, la justicia social y la sostenibilidad. La lucha contra el sinhogarismo tiene una profunda conexión con varios ODS, en concreto:

• **ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles):** este Objetivo pretende lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Para ello, se plantea la meta de asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. El objetivo reconoce la vivienda como un derecho fundamental que permite garantizar la inclusión, la seguridad y el acceso a otros derechos básicos. Asimismo, el Objetivo incide en erradicar los barrios marginales para favorecer la inclusión y plena participación en la comunidad.

• **ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico):** este Objetivo busca generar crecimiento económico inclusivo y sostenido para impulsar el progreso, crear empleos decentes y mejorar los estándares de vida de la población. En la búsqueda de una solución sostenible al sinhogarismo, el empleo decente e inclusivo se convierte en un pilar fundamental. Las metas relevantes en este ámbito son, principalmente, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres; reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados ni cursan estudios ni reciben capacitación, entre otras.

• **ODS 3 (Salud y bienestar):** Este objetivo propone garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. La lucha contra el sinhogarismo contribuye a las metas de lograr la cobertura sanitaria universal; fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas; reducir la mortalidad prematura por enfermedades mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar, entre otras.

5.2.- MARCO EUROPEO PARA COMBATIR EL SINHOGARISMO.

El marco normativo y conceptual que rige en Europa con relación al sinhogarismo y la exclusión residencial viene determinado, al menos, por los siguientes elementos:

Por una parte, el **Pilar Europeo de Derechos Sociales** (en adelante, PEDS) recoge entre sus principios el derecho a la vivienda y la asistencia a las personas sin hogar y, más concretamente, establece que:

• Deberá proporcionarse a las personas en situación de necesidad acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad.

• Las personas en condiciones de vulnerabilidad tienen derecho a una asistencia y una protección adecuadas frente a un desalojo forzoso.

• Deberá facilitarse a las personas sin hogar alojamiento y servicios adecuados con el fin de promover su inclusión social.

La **Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2020**, sobre cómo abordar el porcentaje de personas sin hogar en la Unión Europea. La citada resolución plantea los elementos básicos que deben regir las políticas comunitarias y nacionales de abordaje del sinhogarismo y, entre otras cuestiones recoge las siguientes:

• La carencia de hogar se considera una de las formas más graves de pobreza y privación que debe eliminarse mediante políticas específicas e integradas, llevadas a cabo de manera sostenible abordando los factores de riesgo personales (como las vulnerabilidades individuales) y los factores de riesgo estructural (como la vivienda y el desempleo);

• La Comisión y los Estados miembros deben adoptar una definición marco compartida, así como unos indicadores coherentes para tratar el problema de las personas sin hogar en la Unión, lo que permitiría una comprensión común, una comparación sistemática y una evaluación del alcance de la carencia de hogar en los distintos Estados miembros;

• La Comisión debe proponer un marco europeo que sirva de guía a las estrategias nacionales para las personas sin hogar. Los Estados miembros deben adoptar el principio de "la vivienda, primero", basado en las buenas prácticas desarrolladas en algunos Estados miembros, que contribuya a reducir sustancialmente el porcentaje de personas sin hogar mediante la introducción de planes de acción efectivos y enfoques innovadores;

• Los Estados miembros deben asumir la responsabilidad principal de abordar la situación de las personas sin hogar, trabajando en la prevención y la intervención temprana, que es, a menudo, la manera más rentable y menos perjudicial de hacer frente a la situación de carencia de hogar, asignando un papel más proactivo a los servicios de seguridad social regionales y locales para ayudar a las personas sin hogar a reintegrarse en la sociedad;

• Los Estados miembros y a la Comisión deben mejorar la recopilación de datos pertinentes y comparables. Este proceso se debe realizar con la participación de organizaciones no gubernamentales acreditadas y autoridades locales que trabajan en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, así como en la prestación de servicios a las personas en situación de riesgo o sin hogar;

• Los Estados miembros deben abordar urgentemente la situación de carencia de hogar mediante la adopción de estrategias nacionales integradas a largo plazo, basadas en la comunidad, orientadas a la vivienda para las personas sin hogar, tal como se establece en el paquete de inversión social de la UE; • Los Estados miembros deben facilitar un acceso constante y continuo a centros de acogida de emergencia en toda la UE;

• No obstante, e el recurso a los centros de emergencia debe ser temporal y no constituye una alternativa a soluciones estructurales, tales como la prevención y la provisión de una vivienda y un apoyo social adecuados como respuesta al problema de la carencia de hogar.

La **Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021**, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, reitera algunas de las peticiones previamente señaladas y, entre otras, plantea las siguientes recomendaciones:

• La Comisión debe adoptar medidas más efectivas para ayudar a los Estados miembros a reducir y erradicar el problema de las personas sin hogar como prioridad en el contexto del plan de acción sobre el PEDS;

• Los Estados miembros deben establecer mecanismos para garantizar la seguridad de las personas sin hogar en sus políticas públicas, además de introducir la aporofobia como delito de odio en las políticas de seguridad pública;

• Tanto la Comisión como los Estados miembros deben poner fin al déficit de inversiones en viviendas asequibles con carácter prioritario;

• La Comisión y a los Estados miembros deben seguir aumentando la inversión en la UE en viviendas sociales, públicas, energéticamente eficientes, adecuadas y asequibles, así como en la lucha contra el problema de las personas sin hogar y la exclusión en materia de vivienda;

• La Comisión y los Estados miembros deben desarrollar un enfoque basado en el género en sus políticas de vivienda, en particular dirigidas a mujeres que se enfrentan a situaciones específicas, como por ejemplo la monoparentalidad.

Finalmente, la **Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo, de 21 de junio de 2021,** recoge una serie de compromisos asumidos por las instituciones europeas, nacionales y locales, así como por las entidades del Tercer Sector que intervienen en el ámbito de la exclusión residencial. La Declaración de Lisboa recoge los siguientes compromisos:

• Ninguna persona dormirá a la intemperie por falta de un alojamiento de emergencia, accesible, seguro y adecuado; • Ninguna persona vivirá en alojamientos improvisados o transitorios más tiempo del necesario para conseguir mudarse a una solución de alojamiento permanente;

• Ninguna persona saldrá de un centro (penitenciario, hospitalario, asistencial, etc.) sin una oferta de alojamiento adecuada;

• Se evitarán los desahucios siempre que sea posible y ninguna persona será desahuciada sin recibir asistencia para encontrar una solución de alojamiento adecuada cuando lo necesite;

• Ninguna persona será discriminada por encontrarse en situación de sinhogarismo.

5.3.- MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE REFERENCIA.

España carece de un marco normativo específicamente orientado a la regulación de las políticas para la prevención o erradicación del sinhogarismo. Existen, sin embargo –tanto en el ámbito estatal como autonómico– diversas leyes, estrategias y planes que es necesario tener en cuenta para conocer el marco en el que se han desarrollado –o se habrán de desarrollar– las políticas relacionadas con el sinhogarismo en España a medio y largo plazo. Desde el punto de vista normativo, se destacan dos normas recientemente aprobadas:

• La **Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda**, cuyo objeto es regular, desde las competencias del Estado, las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales para acceder a una vivienda digna, adecuada y asequible, en el marco de las competencias de las comunidades autónomas. La norma también incorpora la protección ante desahucios y la provisión de vivienda alternativa, claves para la prevención del sinhogarismo.

• **El Real Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas**, cuyo objetivo es promocionar la contratación de las personas desempleadas, especialmente de las más vulnerables, contribuir a la creación, al mantenimiento y la mejora de la calidad del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas, así como fomentar el trabajo autónomo y la creación de empleo en el ámbito de la economía social, lo cual permitirá impulsar la inclusión activa de las personas en situación o riesgo de sinhogarismo.

Las **comunidades autónomas**, por su parte, han legislado en materia de vivienda, garantía de ingresos y servicios sociales, si bien en ningún caso estas normas autonómicas regulan de forma específica los servicios orientados a las personas sin hogar, si no, en todo caso, los derechos relacionados con el acceso a la vivienda, por una parte, y con las situaciones de exclusión social, por otra. En todo caso, en este apartado se mencionan algunas normativas autonómicas concretas que abordan de forma específica la problemática de las personas sin hogar:

• Algunas de las leyes autonómicas de Servicios Sociales incluyen en su catálogo de servicios recursos de acogida nocturna, de atención diurna y/o residenciales, específicamente orientadas a las personas sin hogar.

• La regulación de las rentas mínimas de inserción en algunas Comunidades Autónomas contempla, por su parte, algunas disposiciones específicas relacionadas con las personas sin hogar. En la mayor parte de los casos, se trata de la exención de determinados requisitos (empadronamiento mínimo, edad mínima o máxima, etc.)

Podemos señalar tres herramientas estatales de planificación estratégica:

• La **Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y a exclusión social (2019-2023**) aprobada por Acuerdo de Consejo de ministros el 22 de marzo de 2019, establece cuatro metas estratégicas: lucha contra la pobreza, inversión social en las personas, protección social ante los riesgos del ciclo vital, y eficacia y eficiencia de las políticas.

• El **Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025,** en vigor desde el 20 de enero de 2022, contempla, entre otras actuaciones, un programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas en condiciones de vulnerabilidad. Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas en condiciones de vulnerabilidad.

• La **Estrategia Nacional de desinstitucionalización para la buena vida en comunidad**, actualmente en fase de elaboración, responde al mandato internacional y estatal de promover un proceso de transformación del modelo de cuidados de larga duración y del desarrollo de servicios y apoyos comunitarios centrados en la persona, ofreciendo alternativas al modelo asistencial e institucional. La Estrategia se dirige especialmente a las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas menores de edad en el sistema de protección y las personas sin hogar.

6.- ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL SINHOGARISMO EN ESPAÑA, 2.023-2.030.

6.1.- PRINCIPIOS RECTORES.

La **Estrategia Nacional para la Lucha contra el sinhogarismo en España, 2.023-2.030** asume como **principios rectores:**

PREVENCIÓN.	Al objeto de articular medidas de manera anticipada al riesgo de sinhogarismo o llevar a cabo actuaciones de naturaleza temprana para evitar o minimizar el riesgo o sus efectos. Con este enfoque se trata de lograr que no se produzca la situación de sinhogarismo o a menos no se agrave y cronifique.
PERSONALIZACIÓN.	Consiste en individualizar la atención y ofrecer soluciones en función de las necesidades de cada persona. Este principio implica cultivar la capacidad de adaptación y dotar de suficiente flexibilidad a los apoyos y los servicios ofrecidos en el sistema de atención a personas sin hogar para dar respuesta a las necesidades cambiantes o emergentes.
DESINSTITUCIONALIZACIÓN.	Destinada a impulsar los procesos de transición hacia la vida en comunidad y la autodeterminación de las personas a través del cierre de centros e instituciones, el fomento de servicios de cuidado en la comunidad y el impulso de la autonomía de las personas para mantener y dirigir sus proyectos vitales en comunidad.
ORIENTACIÓN A LA VIVIENDA.	Centrado en facilitar el acceso a una vivienda, entendido como un derecho subjetivo, ofreciendo soluciones basadas en la vivienda y generando apoyos y servicios destinados a facilitar el acceso y/o mantenimiento de una vivienda adecuada, así como la autonomía de las personas en situación de sinhogarismo.
ENFOQUE DE GÉNERO E INTERSECCIONAL.	Implica el reconocimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres, así como las múltiples brechas que experimentan distintos grupos de población por cuestiones de orientación sexual, origen étnico o nacionalidad. En ese sentido, las respuestas del sistema de atención a personas sin hogar han de ser sensibles y adaptarse a las necesidades particulares de mujeres, personas LGBTIQ+, inmigrantes y demás grupos poblacionales, en tanto que las desigualdades que viven suponen barreras adicionales para la inclusión, la autonomía y la vida en comunidad.
INNOVACIÓN.	Consiste en impulsar y apoyar la innovación social, aprovechando las oportunidades de experimentación y aprendizaje con el objeto de promover nuevas ideas y enfoques para abordar el sinhogarismo.
RESPONSABILIDAD PÚBLICA.	Las administraciones públicas asumen su responsabilidad en la acción social, facilitando y promoviendo recursos financieros, técnicos e institucionales para posibilitar el desarrollo de políticas y medidas orientadas a mejorar el bienestar, la calidad de vida y la plena inclusión de las personas en situación de sinhogarismo.

6.2.- VISIÓN.

Esta Estrategia aspira a contribuir a los objetivos planteados en la **Declaración de Lisboa**, en tanto que se considera el marco que orienta el desarrollo de las políticas para combatir el sinhogarismo en Europa; sin embargo, siendo conscientes de la gran ambición de la Declaración, el marco estratégico nacional pondrá el foco en la prevención y erradicación del sinhogarismo de calle y la promoción de la desinstitucionalización.

Para lograrlo, la Estrategia impulsará el desarrollo de un **sistema de prevención orientado a la detección, la atención temprana y la reducción de las consecuencias del sinhogarismo**. La prevención estará enfocada en la detección de perfiles en grave riesgo de caer en sinhogarismo, atendiendo a las alertas y vulnerabilidades de cada persona según su situación individual (sexo, edad, origen, discapacidad o enfermedad mental, etc.), buscando activar respuestas rápidas para que ninguna persona pase por una situación de calle, ofreciendo además los recursos y apoyos necesarios para recuperarse de esta experiencia lo más pronto posible.

Asimismo, se pretende reforzar el enfoque de **prevención terciaria para evitar la recaída de personas que han atravesado situaciones de calle y que tienen necesidades complejas**. Asimismo, la Estrategia apuesta por la transformación y adaptación del sistema de atención a personas en situación de calle para que esté basado en apoyos a las personas en la comunidad, de modo que la atención en instituciones sea puntual o de carácter transitorio. Este enfoque implica ofrecer soluciones personalizadas, priorizar las soluciones orientadas a la vivienda y el impulso de la autonomía.

De igual forma, la Estrategia tiene una visión integral que articula el sistema de atención a las personas sin hogar al **ejercicio de la ciudadanía y el pleno goce de los derechos humanos** a través de los servicios que se ofrecen desde las distintas redes de protección mediante mecanismos de coordinación con los distintos niveles competenciales y demás actores implicados.

Por último, esta Estrategia asume el compromiso de generar conocimientos sobre la realidad del sinhogarismo e incorporar los aprendizajes obtenidos de los proyectos experimentales de desinstitucionalización en el ámbito de sinhogarismo financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, favoreciendo así la transformación de las políticas públicas. El conocimiento, la experimentación y el aprendizaje deben generar políticas públicas innovadoras y eficaces en la resolución.

6.3.- ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL.

La Estrategia se articula en torno a dos objetivos generales y 12 objetivos específicos que serán desarrollados en distintos ejes y líneas de actuación.

OBJETIVOS GENERALES.
1.- Erradica el sinhogarismo de la calle.
Este objetivo implica movilizar los recursos necesarios para que nadie duerma en la calle en 2030, activando las respuestas y los recursos necesarios para ofrecer alternativas de alojamiento a las personas en situación de calle según sus necesidades individuales. Además de ofrecer alternativas de alojamiento, este objetivo requiere poner en marcha los apoyos necesarios para evitar que las personas en riesgo caigan en situaciones de calle, incrementar las plazas en vivienda y adaptar la respuesta para ofrecer soluciones personalizadas y orientadas hacia una intervención que ponga el foco en la desinstitucionalización en aras de aumentar la sostenibilidad, la capacidad de acogida y promover las salidas autónomas del sistema.

2.- Prevenir el sinhogarismo de la calle.
Este objetivo implica la detección de las personas en riesgo, ofreciendo los apoyos y ayudas necesarias para evitar que deriven en situaciones de calle. La prevención implica el refuerzo de la coordinación entre sectores (servicios sociales, vivienda, sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, sanidad, sistema de protección de menores, sistema de acogida, etc.) en los distintos niveles competenciales, con el objeto de identificar a las personas en riesgo, con especial énfasis en los casos donde se da una mayor invisibilidad del fenómeno o de intermitencia, como es el del sinhogarismo femenino, y ofrecer apoyos oportunos antes de caer en esta situación.

La Estrategia se desarrolla a través de **4 ejes:**

Eje 1. **Prevención.**	1.- Prevenir la cronificación del sinhogarismo en la calle. 2.- Prevenir y ofrecer una respuesta rápida a las situaciones de calle en perfiles de mayor riesgo y a los recién llegados al sistema de atención al sinhogarismo.
Eje 2. **Promoción de la autonomía.**	3.- Proteger el derecho a la vivienda de las personas en situación de sinhogarismo. 4.- Fomentar la inclusión activa de las personas en situación de sinhogarismo. 5.- Garantizar el derecho a la salud y el bienestar de las personas sin hogar especialmente a aquellas con mayor necesidad como las que requieren apoyo en materia de salud mental, adicciones, discapacidades y protección frente a la violencia de género, trata y prostitución. 6.- Prevenir la discriminación, la criminalización, los delitos de odio y la violencia de género contra las personas en situación de sinhogarismo. 7.- Favorecer la participación de las personas en situación de sinhogarismo.
Eje 3. **Respuestas adaptadas y personalizadas.**	8.- Ofrecer soluciones de alojamiento y apoyos adaptados a las necesidades y deseos de las personas mediante una intervención profesionalizada. 9.- Reorientar el sistema de atención a personas en situación de sinhogarismo hacia recursos comunitarios que fomenten la autonomía y trabajen desde la óptica del proyecto de vida de las personas y la desinstitucionalización.
Eje 4. **Gobernanza y conocimiento.**	10.- Consolidar un sistema de gobernanza multiactor orientado al cambio sistémico. 11.- Mejorar los sistemas de información sobre las personas en situación de sinhogarismo. 12.- Fomentar la innovación en las políticas públicas de erradicación del sinhogarismo y transferencia de aprendizajes.

7.- PLAN DE INCLUSIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 2.016-2.021.

La **Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016**-2021, aprobada por el Gobierno regional en octubre de 2016, reúne las iniciativas que la Administración regional tiene ya en marcha, y también las que están previstas a medio y largo plazo, para lograr la inserción plena en la sociedad madrileña de aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza y de exclusión social, o en riesgo de padecerlas. Se aborda esta problemática utilizando una **doble perspectiva**: por un lado, la de las políticas necesarias para alcanzar ese objetivo (políticas de empleo, sanidad, educación, vivienda, servicios sociales…); por otro, la de las necesidades de diferentes grupos de población que requieren una atención específica para evitar o superar esas situaciones.

Del mismo modo, **el Plan de Inclusión de Personas Sin Hogar de la Comunidad de Madrid 2016-2021** representa una etapa más en el empeño de atender a las personas más vulnerables.

El derecho a disfrutar de una vivienda digna ha sido proclamado en todos los ámbitos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Constitución Española. Nadie debería carecer de un techo que proporcione refugio seguro y unas condiciones de bienestar suficientes.

7.1.- MARCO COMPETENCIAL.

La **Constitución Española** reconoce que:

"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, renovar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social" **(art. 9.2.).**

"No puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" **(art. 14)**.

"Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico … realizando una política orientada al pleno empleo" **(art. 40).**

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación" **(art. 47).**

El **Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid** atribuye a ésta las competencias en *"promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación"* **(Art. 26.1.23).**

La **Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción**, establece que la Comunidad de Madrid *"elaborará periódicamente Planes Regionales contra la Exclusión, en los que se recogerán las medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y favorecer la inserción social de quienes padecen situaciones o riesgo de exclusión"* (Art 36) y que *"La Comunidad de Madrid incluirá a los perceptores de renta mínima de inserción entre las poblaciones de atención prioritaria de los planes de empleo y formación ocupacional, salud, compensación educativa, educación de personas adultas y vivienda, en la forma que reglamentariamente se determine"* (Art 37).

La **Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021**, aprobada por el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo adoptado el día 11 de octubre de 2016, prevé en su objetivo 16 el diseño e implantación de una estrategia integral para la inclusión social de las personas sin hogar.

7.2.- OBJETIVOS.

En síntesis, el Plan de Inclusión de Personas sin Hogar de la Comunidad de Madrid busca:

a) Reforzar el sistema de ayuda a las personas sin hogar.

b) Mejorar innovadoramente su eficacia y eficiencia.

c) Prevenir las crecientes situaciones de sinhogarismo.

d) Actuar con urgencia para que quienes están peor y pernoctan en vías públicas puedan superar dicha situación.

Por ello, los cuatro objetivos que se plantea el Plan son:

a) Prevención y sensibilización.

b) Poner los medios eficaces para que ninguna persona sin hogar pernocte en vías públicas o alojamientos inadecuados.

c) Aumentar drásticamente el acceso que las personas sin hogar tienen a sus derechos y servicios públicos.

d) Aumentar significativamente el número de personas sin hogar que se reintegran en la sociedad.

7.3.- ENFOQUE.

El enfoque del Plan se basa en **el ejercicio efectivo de los derechos** de las personas que se hallan sin hogar, en la **ética de los cuidados** y pone un especial énfasis en la prioridad de la vivienda, la restauración del proyecto vital y su reintegración en la comunidad.

Las personas sin hogar son aquellas a las que la carencia de un alojamiento digno les desarraiga de la comunidad e impide el mantenimiento de su seguridad y proyecto vital. En Europa hay consenso en aplicar la categorización ETHOS *(European Typology on Homelessness and Housing Exclusion)*, elaborada por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA, por sus siglas en inglés), que identifica trece perfiles de *personas sin hogar y exclusión residencial,* agrupados en cuatro categorías.

El Plan de Inclusión de Personas sin Hogar de la Comunidad de Madrid tiene como destinatarios principales las personas que sufren las situaciones A y B *(Sin Techo y Sin Vivienda)* y establece medidas de prevención para evitar que lleguen a ellas otras personas en riesgo social. A los otros dos grupos, C y D *(viviendas inseguras e inadecuadas)* responde de manera específica la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021.

Al tratarse del primer Plan regional en esta materia en la Comunidad de Madrid, sus componentes fundamentales son el **ordenamiento**, la **suficiencia**, **eficacia** y **eficiencia del conjunto de los recursos** que el sistema público dirige a la superación del sinhogarismo. El Plan promueve la **confianza** de las personas sin hogar y su **acceso** a los **servicios generales** en ámbitos como las prestaciones, la salud o la formación laboral, que deberán adaptarse mejor a la atención de estos ciudadanos, en las situaciones en que se encuentren.

Al mismo tiempo, otros servicios **especializados** trabajarán para lograr esa confianza y accesibilidad, así como la recuperación de la autonomía y el proyecto de vida. Se ha de avanzar en la atención **especializada** a perfiles más específicos, según factores como salud, dependencia, discapacidad, edad, sexo u otras variables, cuyo tratamiento aumenta la eficacia de la ayuda.

La intensificación y modernización del sistema requiere dos principios: la **corresponsabilidad** de todos los municipios de la Comunidad de Madrid para atender a las personas sin hogar y la **coordinación** entre las Administraciones y entre sus distintos órganos. El enfoque busca lograr la plena accesibilidad de las personas sin hogar a cada servicio público en el lugar en que se encuentra la persona. Se facilita así su incorporación a la comunidad en la que ya tiene vínculos y evita concentraciones en la capital y en determinadas áreas. Para ello es clave el acceso al empadronamiento en el municipio.

El Plan de Inclusión de Personas sin Hogar de la Comunidad de Madrid se articula a través del trabajo de prevención, la atención temprana y la reducción de riesgos para las personas sin hogar. Constituyen partes relevantes del Plan de Inclusión de Personas sin Hogar la perspectiva de género y la atención prioritaria a los jóvenes y mayores sin hogar, así como las personas LGTBI.

El enfoque de la **ética del cuidado** presta especial atención al trato personalizado, la intimidad y dignidad de las personas, su libertad y autonomía, sus derechos en cada lugar y proceso, así como su participación activa en ellos.

Las personas sin hogar se encuentran en una situación que es posible superar para reducir riesgos y alcanzar otra de mayor seguridad vital, dignidad y autonomía. Para eso es crucial un enfoque de **activación progresiva** que intensifique la recuperación personal, el acceso a **formación** laboral, mejore la **empleabilidad** y la **participación comunitaria**.

La atención a las personas sin hogar requiere una **modernización en la propia metodología** empleada y la introducción de una **cultura de evaluación** para mejorar eficacia y eficiencia. Siendo cruciales la vivienda y la integración en la comunidad, hay que transformar el conjunto de la respuesta para que se priorice el alojamiento en: (a) residencias más especializadas y de menor tamaño (y menor número de personas por habitación), (b) viviendas normalizadas (conocido como enfoque *Housing Led*), evitar en general las concentraciones en un mismo vecindario para que sea factible que se reintegren en la comunidad y (c) aplicar el innovador método *Housing First* para aquellos que están en situaciones crónicas o más graves.

El Plan reconoce la importante labor que hacen las organizaciones de la sociedad civil madrileña así como que, en último término, el papel de reintegración a la comunidad corresponde a vecinos y empleadores. La **sensibilización de la opinión pública y la colaboración de los vecinos** es parte sustancial del enfoque del Plan de Inclusión de Personas sin Hogar. Por ello, procura la **colaboración prioritaria con la sociedad civil y la aplicación de las cláusulas sociales** en la gestión de centros y recursos, ya que ninguna entidad como las organizaciones ciudadanas aporta tanto capital comunitario y valores en la gestión y desarrollo de cada recurso.

En resumen, el enfoque se basa en los siguientes puntos:

a) Ejercicio efectivo de Derechos, ética del cuidado y reducción de daños.

b) Modernización del sistema y aumento de los recursos.

c) Corresponsabilidad de todos los municipios y coordinación interdepartamental

d) Innovación, eficacia y eficiencia de los recursos mediante evaluación.

e) Accesibilidad a los servicios y confianza para su aceptabilidad.

f) Potenciación de los servicios generales y especialización por perfiles.

g) Activación progresiva que intensifique la recuperación personal, empleabilidad y participación comunitaria.

h) Cambio progresivo del modelo de alojamiento a menor tamaño, especialización, no concentración y *Housing First*.

i) Prevención y atención temprana.

j) Perspectiva de género, prioridad de jóvenes y mayores y atención a personas LGTBI.

k) Sensibilización ciudadana, colaboración de los vecindarios, cláusulas sociales y participación prioritaria de las organizaciones ciudadanas.

7.4.- EJES VERTEBRADORES.

En coherencia con el diagnóstico, el Plan de Inclusión de Personas sin Hogar de la Comunidad de Madrid se estructura en torno a **cinco ejes vertebradores**:

1.- **ARTICULACIÓN Y REFUERZO DEL SISTEMA PÚBLICO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR EN CADA TERRITORIO Y EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

Objetivo 1. Articulación del sistema público de atención a personas sin hogar.	. Mesa de Coordinación entre Consejerías. . Grupo Técnico de Municipios. . Grupo Técnico de Entidades. . Consulta a personas sin hogar. . Acuerdo para elaborar Estrategias Municipales Integrales para PSH. . Cartera Regional de Servicios. . Guía Regional de Recursos. . Base Integral de Datos. . Extensión a todas las PSH de la figura del profesional de referencia para el acompañamiento social. . Cooperación internacional con los Consulados.
Objetivo 2. Mejorar la accesibilidad y la confianza de las personas sin hogar en los servicios.	. Empadronamiento en los municipios donde las personas residan. . Trabajo social de calle (no se puede desarrollar en todos los municipios y puede ser asumido por el TS de Zona). . Formación y sensibilización especializada a los servicios generales. . Calidad de los cuidados. . Campaña de sensibilización sobre la confianza en los recursos sociales.

2.- **PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA, VOLUNTARIADO, PROTECCIÓN DE DERECHOS Y CONTRA LOS DELITOS DE ODIO.**

Objetivo 1. Prevención del sinhogarismo.	. Establecer protocolos de detección temprana del sinhohgarismo y potenciar y coordinar los ya existentes. . Refuerzo de los programas de mediación y asesoramiento ante situaciones de pérdida de la vivienda habitual. . Intensificación de la protección y ayuda a los jóvenes, especialmente a jóvenes ex tutelados. . Agilizar y adaptar la tutela de personas adultas sin hogar. . Programa de primera noche.

Objetivo 2. Sensibilización pública.	. Aplicación de las guías periodísticas que establezcan los términos de referencia. . Contenidos mediáticos de sensibilización social en la radio y TV autonómicas. . Medidas de sensibilización a escolares. . Sensibilización y cooperación de las asociaciones de vecinos. . Sensibilización y cooperación de los comercios con locales en calle para atención al público. . Sensibilización y cooperación especial con los dueños y encargados de pequeños negocios de restauración.
Objetivo 3. Incremento y cualificación del voluntariado dedicado a PSH.	. Aumento del número de voluntarios dedicado a PSH. . Evolución de un voluntariado de servicio a un voluntariado de cambio social.
Objetivo 4. Protección contra delitos de discriminación y odio, estableciendo un procedimiento de intervención para estos casos, coordinando con Policía, servicios sanitarios y otros.	. Asesoramiento jurídico a PSH. . Protección de los enseres de las PSH. . Violencia de género. . Formación en género para profesionales que trabajan con población vulnerable.

3.- **PROTECCIÓN VITAL Y CAMBIO EN EL MODELO DE ALOJAMIENTO Y DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO CON QUIENES ESTÁN EN PEOR SITUACIÓN Y MÁS CRONIFICADOS.**

Objetivo 1. Plan de choque para la reducción del sinhogarismo en calle.	. Reducción cualitativa del número de personas que pernoctan en calle con mayor cronicidad y en las peores condiciones. . Desarrollar el modelo Housing First para el trabajo con las PSH que están en las peores condiciones. . Reducción del número de PSH que no disponen de alojamiento durante el día mediante vivienda 24 horas y centros diurnos de activación. . Prioridad de las mujeres sin hogar en el acceso a la vivienda. . Atención social a las emergencias sociales que sufren las PSH.
Objetivo 2. Un modelo de alojamiento plural más personalizador, especializado e integrador.	. Lograr mayor equilibrio entre las modalidades de alojamiento. . Intimidad para los momentos más delicados de la persona, como el final de la vida. . Hacer posible en los alojamientos en la intimidad de las parejas sin hogar.

	. Aumento de las PSH que hacen gestiones para obtener una vivienda propia.
Objetivo 3. Calidad y servicio de los alojamientos.	. Elevar las condiciones de habitabilidad de los pisos y las pensiones. . Carta de servicios de comunicación vinculados a los alojamientos. . Custodia de bienes y documentación personal fundamental.
Objetivo 4. Mejorar la salud de las PSH.	. Favorecer el acceso a servicios básicos de alimentación, higiene, vestido y lavado de ropa a todas las PSH que no accedan a alojamiento. . Intensificación de la perspectiva sociosanitaria. . Documentación para ejercer el derecho a la protección de la salud. . Apoyo para mejorar los hábitos alimenticios y deportivos. . Atención a convalecientes. . Trabajar en la reducción de la incidencia de enfermedades graves y prioridad de las personas con enfermedades crónicas. . Apoyar los programas de rehabilitación de adicciones.

4.- **AUTONOMÍA, ACTIVACIÓN Y EMPLEABILIDAD PARA LA RESTAURACIÓN DEL PROYECTO VITAL.**

Objetivo 1. Restauración del proyecto vital.	. Mejorar innovadoramente los servicios de apoyo psicológico. . Trabajar innovadoramente con parejas sin hogar. . Promover proyectos de arte e intervención social que generen sensibilización en la opinión pública.
Objetivo 2. Maximizar el acceso a prestaciones por edad y por discapacidad.	. Favorecer que las personas mayores accedan a prestaciones económicas. . Ayudar a las PSH con discapacidad reconocida para que accedan a una prestación económica. . Ayudas a la dependencia.
Objetivo 3. Mejorar el conocimiento y soporte a la Renta Mínima de Inserción.	. Conocimiento de la RMI. . Mejorar el soporte de RMI como servicio para la reintegración social. . Transiciones al empleo de personas que reciben RMI.
Objetivo 4. Aumentar sustantivamente la formación laboral de las PSH.	. Favorecer la empleabilidad de las PSH. . Contratos de aprendizaje-servicio.
Objetivo 5. Aumentar el número de PSH que buscan empleo e incrementar las oportunidades de empleo protegido.	. Aumentar el número de personas en búsqueda de empleo. . Cláusulas sociales. . Potenciación de las empresas de inserción.

Objetivo 6. Renegociación de deudas y patrimonio.	. Renegociación de deudas y patrimonio.
Objetivo 7. Reintegración comunitaria.	. Mejorar la inclusión digital de las PSH. . Promover la participación activa de las PSH en eventos sociales y culturales. . Promover la participación política de las PSH.

5.- **MEJORA DEL CONOCIMIENTO SOBRE PERSONAS SIN HOGAR Y DEL COSTE-BENEFICIO Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, SERVICIOS Y RECURSOS PÚBLICOS O FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS.**

Objetivo 1. Mejorar el conocimiento sobre las PSH en la región.	. Colaboración con las encuestas del INE. . Realizar recuentos nocturnos en toda la Comunidad de Madrid. . Realizar estudios estratégicos sobre las PSH.
Objetivo 2. Avanzar en la modelización metodológica y la cultura de evaluación de las políticas, programas y recursos, teniendo en cuenta la perspectiva de género.	. Avanzar en la modelización metodológica de la acción con PSH. . Avanzar en la calidad de los centros y organizaciones que intervienen en los itinerarios de las PSH. . Avanzar en la evaluación del impacto de los servicios y recursos. . Evaluación del coste/beneficio de las políticas públicas de PSH.

8.- LAS PERSONAS SIN HOGAR EN LAS ESTRATEGIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. LARES: ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL SINHOGARISMO, 2.015-2.020.

La Estrategia Municipal para la prevención y atención al sinhogarismo 2.015-2.020 del Ayuntamiento de Madrid se sitúa dentro de la línea de la UE de intervención con este colectivo:

- Los **Fondos Estructurales y de Inversión de la UE** persiguen unos objetivos temáticos determinados en el Marco Estratégico Común (MEC) para el nuevo periodo (2014-2020), que se alinean con los Objetivos de la Estrategia 2020. En este sentido, dentro del Objetivo Temático nº 9: **Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza**, y según la prioridad de inversión nº 4:, plantea la **mejora del acceso a unos servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general**; el **Fondo Social Europeo** financia acciones para la: **mejora del acceso a unos servicios sociales de calidad, asequibles y sostenibles, por ejemplo los servicios de formación y de empleo, los servicios para las personas sin hogar**, los servicios de cuidados fuera de la escuela y los servicios de asistencia infantil y de cuidados de larga duración.
-

- La **Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea**, establece en su artículo 34.3: "**Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales**".
- Como resultado, en diferentes países europeos se cuenta con lo que denominan como estrategias nacionales y/o regionales de respuesta a las Personas Sin Hogar.

8.1.- CONCEPTUALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN.

El "Sinhogarismo" se conforma como una realidad social presente en las sociedades desarrolladas de los países occidentales y principalmente, está presente en las grandes ciudades, como es el caso de Madrid, Barcelona, Paris, Bruselas, ... Representa, sin duda, la **manifestación más extrema de la exclusión social**. Desde el punto de vista humano y social, la presencia de una sola persona en calle debe de movilizar a las instituciones, entidades, técnicos y ciudadanos, en el sentido de dar una respuesta a las necesidades personales y sociales que presenta cualquier persona que se encuentra en situación de calle. Una cuestión inicial es establecer a qué se refiere el fenómeno "personas sin hogar".

La Estrategia Madrileña se centra en los grupos sociales más vulnerables recogidos en la tipología Ethos, concretamente en las siete primeras categorías.

8.2.- CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA: EL FENÓMENO DEL SINHOGARISMO EN LA CIUDAD DE MADRID.

En relación a los datos de la ciudad de Madrid, desde el año 2006 se vienen realizando los correspondientes recuentos nocturnos, hasta la fecha se han desarrollado 6 y esta ciudad fue pionera en nuestro país en la aplicación de esta novedosa metodología. En el último recuento de 'sin techo' realizado en el año 2012 por el SAMUR SOCIAL Ayuntamiento de Madrid, en el que participaron 915 ciudadanos voluntarios contactaron con 701 personas que se encontraban pernoctando en la calle en una noche de dicho año. El 87% eran varones, con una media de edad de 46,36 años y el 52% extranjeros; más de la mitad (un 54%) ha pasado en la calle más de dos años de su vida; una cuarta parte (24,3%), en cambio, lleva menos de cuatro meses.

8.3.- EL PUNTO DE PARTIDA.

El Punto de Partida La elaboración de la presente Estrategia Municipal ha partido del **proceso de desarrollo y consolidación** experimentada en los últimos diez años por la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar que en el año 2004 contaba con un presupuesto próximo a los 4 millones de euros y actualmente, dispone de más de 15 millones de euros. Esto ha permitido la configuración de una amplia y diversificada Red de centros de atención a Personas Sin Hogar en la ciudad de Madrid; una Red que se ha configurado desde los siguientes **criterios**:

• Diversificación.

• Especialización.

• Responsabilidad institucional.

• Adaptabilidad.

• Individualización.

• Globalidad.

• Continuidad en los procesos.

• Flexibilidad.

• Complementariedad y trabajo en red.

• Colaboración público / privada.

La organización de los recursos de la Red se presenta bajo dos perspectivas, en primer lugar, desde la perspectiva de la **detección de situaciones de exclusión, tanto en momentos iniciales de los procesos de pérdida de la vivienda, como de personas que llevan largos períodos de tiempo teniendo la calle como hábitat**. En segundo lugar, los recursos se organizan en lo que podríamos denominar "**escalera hacia la incorporación social**", donde cada recurso se constituye en una oportunidad para la inclusión, ofreciendo la posibilidad de incorporación a la Red cualquiera que sea el proceso de inserción/exclusión de cada persona.

En este texto se expone un itinerario ideal según una secuencia que va de mayor a menor deterioro personal y exclusión social, lo que no significa que todas las personas tengan que realizar el mismo recorrido, sino que sus necesidades se pueden satisfacer en un tipo de recurso u otro, diseñado para atender diferentes situaciones que no se conciben como estancas, sino dinámicas y, por tanto, requieren **espacios adaptados a las diferentes necesidades personales**. Este itinerario comenzaría en los dispositivos de baja exigencia, pasaría por los de media exigencia y finalizaría en los de alta exigencia hasta lograr la vida independiente de las instituciones. Los Equipos de Calle de Samur Social resultan polivalentes en tanto que atienden tanto situaciones iniciales, como consolidadas de desarraigo y, por tanto, pueden vincular a la persona al recurso que mejor responda a las necesidades del momento de la persona.

8.4.- CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA.

La presente Estrategia parte de un **principio básico**: **Poner a la persona en el centro de la intervención social municipal**; con un **objetivo clave**: **que nadie duerma en la calle por falta de recursos adecuados a sus necesidades**.

Para ello:

- Se analizará toda la Red Municipal de Atención a las personas sin hogar especializando los recursos en función del perfil y necesidades de las personas usuarias.

- Se fomentará el empoderamiento de las personas sin hogar desde la perspectiva de sus derechos fundamentales con especial atención al ámbito económico y laboral, de la vivienda, de la salud y de la participación social.

- Se establecerán mecanismos de coordinación intramunicipal e interadministrativa para prevenir situaciones de sinhogarismo.

La Estrategia Municipal de Erradicación del "sinhogarismo" en la ciudad de Madrid supone un salto cualitativo en relación a las actuaciones que hasta ahora se ha venido proporcionando, desde la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar. La perspectiva desarrollada hasta ahora centraba su foco de actuación en la movilización de los recursos sociales. Por el contrario, la presente estrategia supone un **compromiso por la trasversalidad** y por tanto, los objetivos y las medidas que la integran suponen **abrir la perspectiva a la participación de un mayor número de agentes institucionales y sociales así como de las propias Personas sin Hogar**. El desarrollo de esta nueva perspectiva o enfoque, posibilita generar nuevas oportunidades para los ciudadanos que, por diversas circunstancias, se encuentran en las diferentes etapas de la exclusión social y residencial.

Esta Estrategia se articula a través de los siguientes **ejes.** En primer lugar, la **sensibilización y compromiso social de la ciudadanía con los procesos de riesgo exclusión y sobre todo, con las personas que ya se encuentran inmersos en las situaciones de "sinhogarismo**". La exclusión es un fenómeno social que requiere, para su respuesta de la implicación de toda la sociedad y por ello, resulta imprescindible articular medidas tendentes a favorecer un acercamiento de la ciudadanía a estas difíciles situaciones personales y sociales.

Otro de los ejes se basa en actuar para **evitar el desarrollo de procesos de exclusión**. El desarrollo de actuaciones preventivas supone un reto en el marco de esta Estrategia ya que si conseguimos evitar el desarrollo e instauración de situaciones personales y colectivas de exclusión residencial, supondrá un salto cualitativo en la medida que se conseguirá muchos ciudadanos no tengan que acceder a la Red especializada de atención a las Personas Sin Hogar.

Contar con una red estable de atención de calidad y flexible supone una condición básica de la presente Estrategia. En este sentido, partiendo del análisis de las actuales debilidades y fortalezas de la Red de atención a Personas Sin Hogar, se procederá a presentar las correspondientes propuestas que permitan mejorar la actual Red, en el ámbito de la Calidad y sobre todo, en la articulación de medidas que permitan generar oportunidades nuevas de intervención.

El fenómeno social del "sinhogarismo" se configura como la expresión más extrema de la exclusión residencial, donde la necesidad de vivienda se configura como uno de los aspectos que caracterizan esta situación. Por ello, se plantea en esta estrategia **la vivienda como un instrumento para alcanzar la ciudadanía**. Contar con una vivienda supone garantizar la estabilización personal, emocional y social de las personas sin hogar y, por tanto, muchos de los derechos de ciudadanía se alcanzan a través de la vivienda; el empadronamiento, la cartilla sanitaria, las prestaciones económicas, documento nacional de identidad, recibir correo, etc....

Por ello, en la presente estrategia se van a incorporar medidas en la línea de posibilitar el acceso a la vivienda de ciudadanos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial y especialmente, en las personas que ya se encuentran insertos en situaciones estables de exclusión residencial.

Sin lugar a duda, uno de los elementos más integradores es el **empleo** y por ello, en la presente estrategia se plantea el **desarrollo de medidas para que el empleo se configure como un agente facilitador de la inserción social**. Supone un salto cualitativo en las actuaciones que hasta ahora se viene desarrollando en el ámbito de la atención a las Personas Sin Hogar, muy centrada en la actualidad en los aspectos de carácter asistencial. Por ello, esta Estrategia se plantea como una de sus líneas básicas de actuación los aspectos relacionados con el empleo y se procederán a incorporar medidas concretas en este ámbito.

Objetivo General.	Que nadie duerma en la calle en la ciudad de Madrid en el año 2020.
Objetivos Específicos.	- Prevenir las situaciones de sinhogarismo. - Establecer programas de intervención temprana que eviten la cronificación de la situación de calle. - Diseñar itinerarios individualizados de intervención para el empoderamiento de cada Persona Sin Hogar.

ÁREAS DE ACTUACIÓN.

ÁREA 1: DE ESTUDIO Y SENSIBILIZACIÓN

Objetivo 1.1: Conocer la realidad del sinhogarismo en la ciudad de Madrid.

Actuaciones:

1.1.1. Realizar investigaciones y/o estudios que identifiquen las características, problemáticas y tipologías de las personas sin hogar en la ciudad de Madrid.

1.1.2. Analizar las historias de vida de las personas sin hogar alojadas en los recursos municipales al objeto de identificar los hitos vitales susceptibles de provocar la situación de sinhogarismo.

1.1.3. Crear espacios de discusión entre personas sin hogar para generar grupos de debate y reflexión sobre las experiencias vitales desencadenantes de la situación de sinhogarismo.

1.1.4. Mantener los recuentos bianuales y los semestrales internos que permitan tener un conocimiento cuantitativo y cualitativo actualizado del sinhogarismo en la ciudad de Madrid.

Objetivo 1.2: Sensibilizar a la sociedad en general sobre el fenómeno del sinhogarismo.

Actuaciones:

1.2.1 Analizar las reclamaciones y sugerencias de la población en relación con las personas sin hogar.

1.2.2 Realizar campañas de sensibilización a la población en general sobre el fenómeno del sinhogarismo.

1.2.3 Elaborar una guía dirigida a los medios de comunicación para un correcto tratamiento de las noticias relacionadas con las personas sin hogar.

1.2.4 Participar en los medios de comunicación con el fin de visibilizar la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar.

1.2.5 Realizar jornadas de puertas abiertas en los Centros de Acogida municipales.

1.2.6 Desarrollar programas de Mediación con el entorno de los Centros de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar.

1.2.7 Desarrollar programas de Mediación con el entorno de los Centros de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar.

1.2.8 Visibilizar el Programa Municipal de Atención a Personas Sin Hogar a través de la página Web Municipal.

ÁREA 2: DE PREVENCIÓN.

Objetivo 2.1: Detectar en sus fases iniciales procesos graves de exclusión social susceptibles de derivar en situaciones de sinhogarismo.

Actuaciones:

2.1.1. Desarrollar un instrumento técnico que, basado en la tipología ETHOS, permita a la Red de Atención Social Primaria detectar situaciones graves de exclusión social.

2.1.2 Establecer servicios de mediación y asesoramiento ante situaciones de desahucio o lanzamiento de las personas y/o familias de su vivienda habitual.

2.1.3 Aumentar el parque de Viviendas Solidarias con alquileres por debajo del precio de mercado y nunca por encima del 30% de los ingresos de la unidad familiar.

2.1.4 Establecer programas de acompañamiento social para las familias con Vivienda Solidaria asignada que lo precisen.

2.1.5 Implantar, dentro del Samur Social, un protocolo de intervención de urgencia que permita activar cuantos recursos sean necesarios para evitar la cronificación de las situaciones incipientes de sinhogarismo.

2.1.6 Establecer protocolos de derivación para la atención y alojamiento a personas desinstitucionalizadas, especialmente jóvenes.

2.1.7 Establecer protocolos de alta hospitalaria para que nadie tenga que recuperarse de su enfermedad en la calle.

ÁREA 3: DE EMPODERAMIENTO.

Objetivo 3.1: Garantizar unos ingresos mínimos a las personas sin hogar que participen activamente en procesos de reintegración social.

Actuaciones:

3.1.1 Acercar los derechos y prestaciones sociales a quienes, por su situación de calle, presentan mayor riesgo de exclusión.

3.1.2 Establecer una ayuda social de emergencia a todas las personas sin hogar que acepten incorporarse a un itinerario integral de reintegración a la vida normalizada.

3.1.3 Agilizar la tramitación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) para las personas que hayan iniciado procesos estables de intervención.

3.1.4 Incrementar la dotación de efectivos de Samur Social dedicados a la gestión de la RMI.

3.1.5 Agilizar la tramitación de Ayudas de Emergencia para el pago de alojamiento en casos de emergencia y situaciones iniciales de sinhogarismo.

3.1.6 Mejorar la coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria y con la Comunidad de Madrid para la gestión de las Ayudas económicas y la RMI.

Objetivo 3.2: Garantizar que ninguna Persona Sin Hogar duerma en la calle por falta de recursos adecuados a sus necesidades.

Actuaciones:

3.2.1 Ampliar la Red Municipal de Atención con una oferta variada y flexible a las necesidades y circunstancias vitales de las personas.

3.2.2 Garantizar la existencia de recursos de acogida para núcleos familiares y/o de convivencia adaptados a sus necesidades.

3.2.3 Analizar la Red de Atención Municipal en función de los perfiles de las personas atendidas para ajustar el tipo de alojamiento ofertado a sus necesidades y momento vital.

3.2.4 Promover la existencia de pisos individuales y minirresidencias especialmente para jóvenes y personas desinstitucionalizadas.

Objetivo 3.3: Desarrollar una política integral de inserción laboral que atienda a las peculiaridades y necesidades de las Personas Sin Hogar.

Actuaciones:

3.3.1 Realizar campañas dirigidas al empresariado madrileño para incentivar la contratación de personas sin hogar.

3.3.2 Realizar actividades de formación en ámbitos de actividad demandados por el mercado laboral.

3.3.3 Estudiar la inclusión en los contratos municipales de cuotas de contratación de Personas sin Hogar.

3.3.4 Impulsar el emprendimiento y el autoempleo entre las PSH atendidas por la Red Municipal de Atención.

3.3.5 Promover programas de microcréditos para impulsar el emprendimiento de las Personas Sin Hogar atendidas por la Red Municipal de Atención.

3.3.6 Implantar programas de mentoring para promover la incorporación laboral de las Personas Sin Hogar.

Objetivo 3.4: Promover la participación activa de las personas sin hogar en los asuntos que les afectan.

Actuaciones:

3.4.1. Modificar el Reglamento del Foro Técnico de las Personas sin Hogar para dar entrada en el mismo a las Personas sin Hogar.

3.4.2. Implantar en los Centros de Acogida Municipales Mesas de Participación de las personas acogidas.

3.4.3 Promover la participación de las Personas Sin Hogar en las asociaciones de vecinos y otras organizaciones de participación ciudadana de los entornos en que se ubican los recursos de la Red de Personas Sin Hogar.

3.4.4 Elaborar de manera participada un catálogo de derechos, deberes y sanciones socioeducativas para los Centros de Acogida de la Red Municipal de Atención.

Objetivo 3.5: Promover programas de voluntariado dentro de la Red Municipal de Atención a las Personas sin Hogar.

Actuaciones:

3.5.1. Promover la participación de voluntariado social y cultural en los centros de la Red de atención a Personas sin hogar.

3.5.2. Promover la participación de las personas atendidas en la Red Municipal en programas de voluntariado.

Objetivo 3.6: Promover hábitos de vida saludables entre las Personas sin Hogar atendidas por la Red Municipal.

Actuaciones:

3.6.1. Diseñar programas de prevención de la salud adaptados a las circunstancias personales y vitales de las Personas Sin Hogar atendidas por la Red Municipal.

3.6.2. Establecer recursos de consumo controlado en los Centros de Atención a las Personas Sin Hogar.

3.6.3 Promover la realización de reconocimientos ginecológicos entre las mujeres atendidas por la Red Municipal.

ÁREA 4: DE COORDINACIÓN.

Objetivo 4.1: Garantizar el principio de transversalidad en la política de atención a las Personas Sin Hogar.

Actuaciones:

4.1.1 Constituir una Mesa Institucional para la Erradicación del Sinhogarismo en que estén representadas todas las Áreas de Gobierno con competencia en esta materia y los Distritos cuyos representantes tengan rango de Dirección General/Gerentes para el impulso político de la Estrategia.

4.1.2 Poner en marcha una Mesa Técnica encargada del seguimiento y evaluación de la Estrategia.

Objetivo 4.2: Promover la coordinación con las Redes públicas y privadas de atención a las Personas Sin Hogar.

Actuaciones:

4.2.1 Reforzar la colaboración con los servicios municipales y autonómicos competentes en materia de salud mental y drogodependencias para adecuar la atención a las necesidades de las PSH con estas problemáticas.

4.2.2 Promover una Red de Grandes Ciudades nacionales y extranjeras para el intercambio de buenas prácticas e iniciativas en materia de prevención del sinhogarismo y atención a las PSH.

4.2.3 Promover una Red de Grandes Ciudades nacionales y extranjeras para el intercambio de buenas prácticas e iniciativas en materia de prevención del sinhogarismo y atención a las PSH.

4.2.4 Extender los Equipos Multidisciplinares de Prevención del Chabolismo/Asentamientos Urbanos a todos los distritos de la ciudad.

4.2.5 Ampliar los convenios y protocolos de colaboración con entidades y plataformas de entidades que trabajan con Personas Sin Hogar en la ciudad de Madrid.

Bibliografía

. MUÑOZ LÓPEZ, Manuel y otros; "Características de las personas sin hogar en España: 30 años de estudios empíricos". Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria. Vol. 3, nº 2. 2.003.

. CABRERA, Pedro José y RUBIO, María José; "Las personas sin hogar, hoy". Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

. CABRERA, Pedro José; "Huéspedes del aire. Sociología de las personas sin hogar en Madrid". Universidad Pontifica de Comillas. Madrid, 1.998.

. CABRERA, Pedro José; "La acción social con personas sin hogar en España". Cáritas Española. Madrid, 2.000.

. **Notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística**. Encuesta a las personas sin hogar. 21 de diciembre de 2.012.

. García Luque, Olga; "Cómo medir la exclusión residencial". Universidad de Murcia. http://www3.uah.es/congresoreps2013/Paneles/panel7/sesion3/olga@um.es/TCPonenciaREPSOGL.pdf

. Guía Housing First Europa. Junio de 2.016. FEANTSA.
https://housingfirsteurope.eu/assets/files/2016/11/Gui%CC%81a-Housing-First-Europa.pdf

. Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España, 2.023-2.030.

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/servicios-sociales/Personas-sin-hogar/docs/EstrategiaPSH20232030.pdf

. Plan de Inclusión Social de personas sin hogar de la Comunidad de Madrid, 2.016-2.021.
https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/302_387_guia_personas_sin_hogar_0.pdf

. LARES. Estrategia municipal para la prevención y atención al sinhogarismo, 2.015-2.020.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/SamurSocial/NuevoSamurSocial/ficheros/LARES.%20Estrategia%20Municipal%20erradicaci%C3%B3n%20sinhogarismo%202015-2020.pdf